AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

REUMATOLOGÍA

Inmunología Clínica

24 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Artritis Inflamatorias, Cristales y Diagnóstico Articular

★☆☆ 9.1. Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial 3
★★★ 9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos GES 4
★★★ 9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) 5
★★☆ 9.4. Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada GES 6
★☆☆ 9.5. Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto GES 7

02 Artritis Reumatoide y Enfermedades del Tejido Conectivo

★★★ 9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares GES 8
★★★ 9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES GES 9
★★☆ 9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal GES 10
★☆☆ 9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora GES 11
★☆☆ 9.10. Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas GES 12

03 Esclerosis Sistémica, Miopatías Inflamatorias y Síndromes Autoinmunes

★★☆ 9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico GES 13
★★☆ 9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal 15
★★☆ 9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto 16
★☆☆ 9.14. Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal 18
★☆☆ 9.15. Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) 19

04 Espondiloartritis Seronegativas y Enfermedad de Behçet

★★☆ 9.16. Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico 20
★★☆ 9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF GES 21
★★★ 9.18. Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII 22
★★★ 9.19. Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento 23
★★★ 9.20. Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis 24

05 Vasculitis Sistémicas, Reumatología de Partes Blandas y Metabolismo Óseo

★★☆ 9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu 25
★★★ 9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) GES 27
★☆☆ 9.23. Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS GES 29
★★☆ 9.24. Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica GES 30

Números que tienes que saber 31
Fármacos de primera línea 34
GES de la especialidad 35
Plan de repaso de 7 días 37
Índice por prioridad ★ 38

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

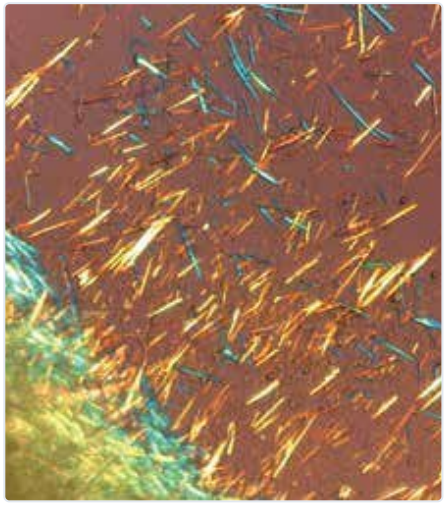
Muy Alta · Pregunta angular de urgencias reumatológicas y medicina interna

1.11.1.015 Monoartritis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Estudio de líquido sinovial · Punción articular de rodilla · Gram líquido articular

LO QUE TE PREGUNTAN

- Toda monoartritis aguda se considera séptica hasta que la artrocentesis y el análisis de líquido sinovial demuestren lo contrario.
- La artrocentesis diagnóstica debe realizarse SIEMPRE antes de administrar la primera dosis de antibióticos.
- **Líquido séptico típico**: > 50.000 leucocitos/mm³ con > **90%** PMN, aspecto purulento y glucosa marcadamente disminuida (< **50%** plasmática).
- **Líquido inflamatorio**: 2.000 a 50.000 leucocitos/mm³ con PMN > **50%** (Gota, Condrocalcinosis, Artritis Reumatoide).
- La única contraindicación absoluta de artrocentesis es la infección cutánea activa sobre el trayecto de punción (celulitis).
- La coexistencia de microcristales y gérmenes piógenos es posible; ante la duda con líquido purulento, siempre cubrir infección bacteriana.



CRISTALES DE URATO
Manual CTO Reumatología 14.ª ed., p. 49

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: MONOARTRITIS AGUDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

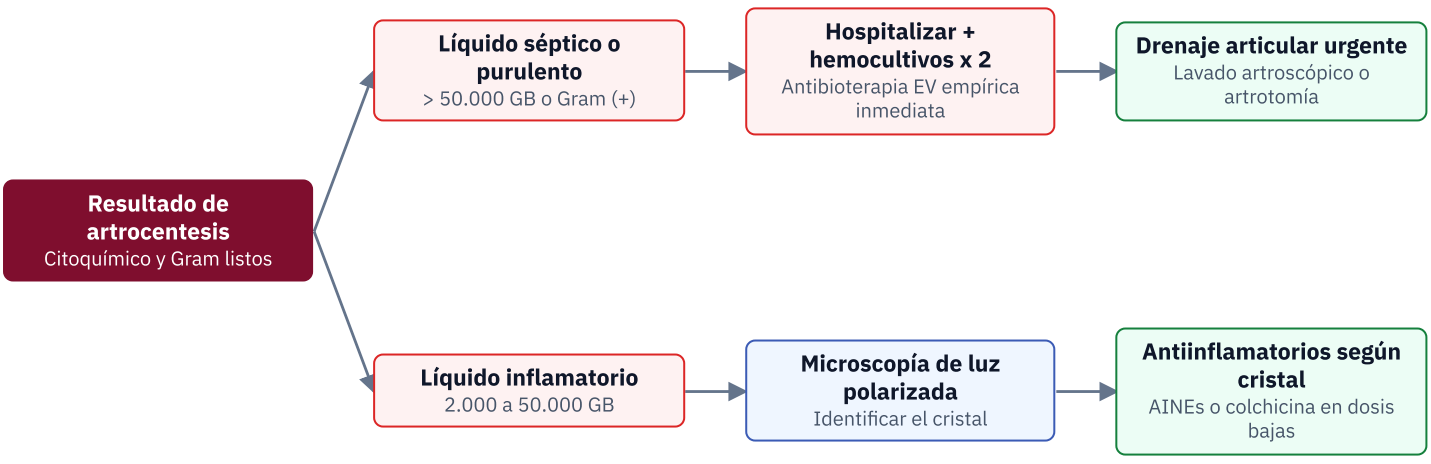


TABLA 9.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL LÍQUIDO SINOVIAL EN MONOARTRITIS AGUDA

TIPO DE LÍQUIDO	ASPECTO Y COLOR	LEUCOCITOS (/MM³)	% PMN	GLUCOSA SINOVIAL	ETIOLOGÍAS TÍPICAS
Normal	Transparente, pajizo, filante	< 200	< 25%	= Glicemia	Articulación sana
Tipo I (No Inflamatorio)	Claro a amarillo claro	200 – 2.000	< 25%	= Glicemia	Artrosis, meniscopatía, trauma leve
Tipo II (Inflamatorio)	Amarillo turbio, no filante	2.000 – 50.000	> 50%	Levemente disminuida	Artritis reumatoide, gota, pseudogota, EA
Tipo III (Séptico)	Opaco, francamente purulento	> 50.000 (hasta >100k)	> 90%	< 50% de glicemia	S. aureus, Streptococcus, Neisseria gonorrhoeae
Tipo IV (Hemorrágico)	Rojo intenso / sanguinolento	Similar a sangre	Similar a sangre	= Glicemia	Trauma capsuloligamentoso, hemofilia, prótesis

REGLA DE ORO **Toda monoartritis es séptica** — Hasta que la artrocentesis demuestre lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **3–8** (págs. 8–9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 9.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.11.2.001 Artritis séptica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Punción articular de rodilla · Estudio de líquido sinovial · Infecciones osteoarticulares · Osteomielitis · Cultivo y antibiograma en infecciones osteoarticulares y heridas

LO QUE TE PREGUNTAN

- Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente (> **60%**) en la artritis séptica del adulto.
- Neisseria gonorrhoeae debe sospecharse en adultos jóvenes con síndrome artritis-dermatitis y tenosinovitis migratoria.
- El drenaje articular (artroscopía, artrotomía o punciones evacuadoras repetidas) es tan vital como los antibióticos endovenosos.
- El esquema empírico inicial habitual es Cefazolina **2 g** c/**8h** EV (o Cloxacilina **2 g** c/**4h** EV); agregar Vancomicina ante riesgo de SAMR.
- En artritis gonocócica el tratamiento de elección es Ceftriaxona **1-2 g** EV al día asociada a cobertura de Chlamydia con azitromicina.
- En infecciones protésicas por estafilococo, la adición de Rifampicina es obligatoria para erradicar bacterias adheridas al biofilm.



DERRAME ARTICULAR
Wikimedia Commons «Knee Effusion.jpg», CC BY-SA 4.0, James Heilman, MD

ALGORITMO · ALGORITMO DE MANEJO URGENTE: ARTRITIS SÉPTICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

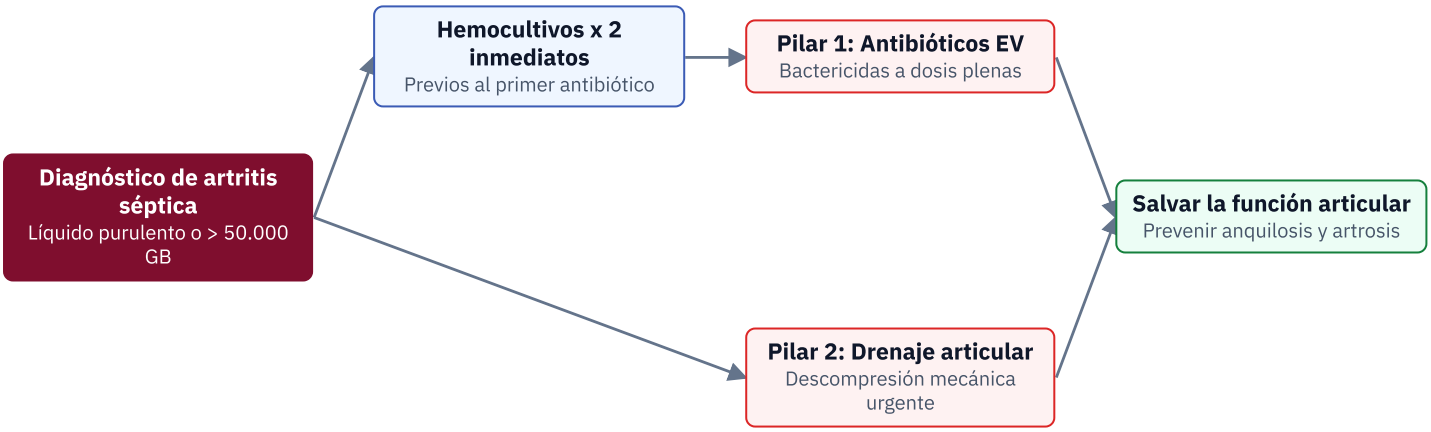


TABLA 9.2 · ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS EMPÍRICOS EN ARTRITIS SÉPTICA

ESCENARIO CLÍNICO	MICROORGANISMO SOSPECHOSO	ESQUEMA EMPÍRICO DE ELECCIÓN	ALTERNATIVA / ALERGIA	DURACIÓN TOTAL
Adulto sano sin factores de riesgo	S. aureus sensible (SASM), Streptococcus	Cefazolina 2 g c/8h EV o Cloxacilina 2 g c/4h EV	Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV	3 – 4 semanas
Riesgo SAMR / Catéter / UCI	SAMR (meticilino resistente)	Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV	Daptomicina 8-10 mg/kg/día EV	4 semanas
Adulto joven activo sexualmente	Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona 1-2 g c/24h EV + Azitromicina 1g VO	Ciprofloxacino (si sensible) o Espectinomicina	7 – 10 días
Anciano frágil / ITU / Drogas EV	Bacilos Gram (-) entéricos, Pseudomonas	Ceftriaxona 2 g c/24h EV + Cefazolina (o Cefepime 2g c/8h)	Meropenem 1 g c/8h EV	4 – 6 semanas
Prótesis articular con biofilm	S. aureus, S. epidermidis	Esquema anti-estafilocócico + Rifampicina 300mg c/12h VO	Linezolid 600 mg c/12h VO	3 – 6 meses

REGLA DE ORO **Staphylococcus aureus es el número 1** — En todas las edades y prótesis

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **9–13** (pág. 9) · solucionario págs. 22–23.

Clase 9.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.11.2.002 Gota aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

También: Condrocalcinosis · Estudio de líquido sinovial

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Gota**: Cristales de urato monosódico en aguja con birrefringencia intensamente NEGATIVA (amarillos paralelos).
- **Pseudogota / Condrocalcinosis**: Cristales de pirofosfato de calcio romboidales con birrefringencia débilmente POSITIVA (azules paralelos).
- El ácido úrico sérico puede ser normal o bajo durante la crisis gotosa aguda (hasta en un **30-40%** de los casos).
- **REGLA DE ORO**: Durante la crisis aguda NUNCA se debe iniciar Alopurinol ni modificar su dosis si ya venía tomándolo.
- El tratamiento de la crisis gotosa se realiza con AINEs plenos, Colchicina (**1 mg** + **0.5 mg**) o Prednisona (de elección en ERC/úlcera).
- El Alopurinol se inicia **2 a 4 semanas** después de resuelta la crisis, a dosis baja (**100 mg**/d) y titulando cada **4 semanas**.



TOFOS EN LAS MANOS
Manual AMIR Reumatología, p. 19

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: GOTA Y CONDROCALCINOSIS

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

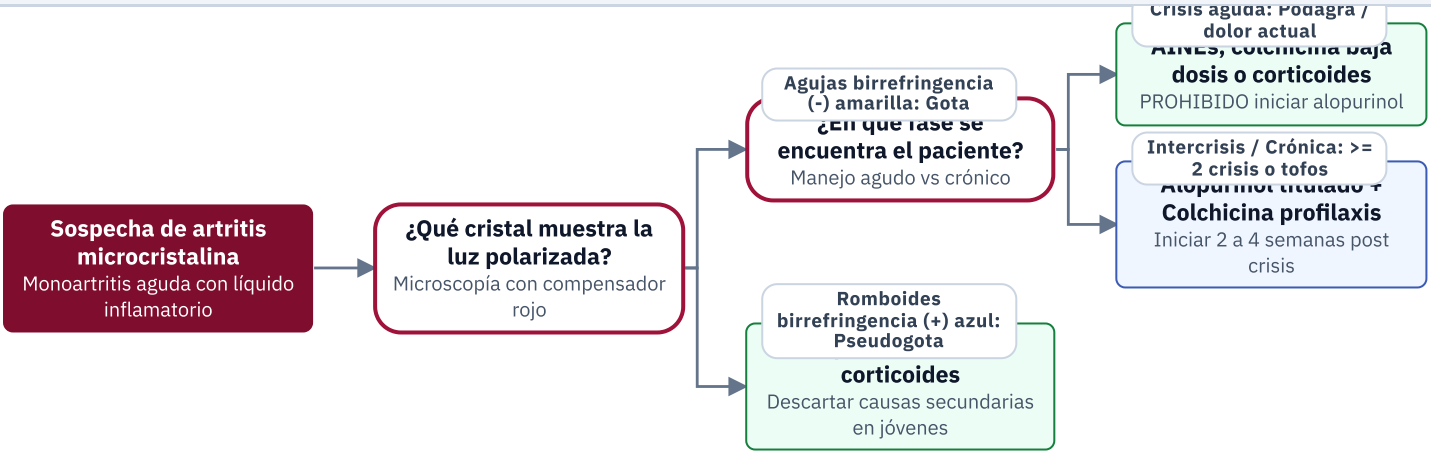


TABLA 9.3 · DIFERENCIAS CRÍTICAS ENTRE GOTA Y CONDROCALCINOSIS (PSEUDOGOTA)

CARACTERÍSTICA	GOTA (URATO MONOSÓDICO)	CONDROCALCINOSIS / PSEUDOGOTA (CPPD)
Cristal responsable	Urato monosódico monohidratado (UMS)	Pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)
Morfología microscópica	Forma de aguja fina, bordes afilados	Forma romboidal, rectangular o poligonal
Birrefringencia (luz polarizada)	Negativa INTENSA (Amarillo paralelo)	Positiva DÉBIL (Azul paralelo)
Articulación más frecuente	1ra Metatarsofalángica (Podagra > 50%)	Rodilla (> 50%), muñeca, sínfisis púbica
Signos radiológicos típicos	Erosiones en sacabocado con borde colgante (Martel)	Calcificación lineal de meniscos y cartílago hialino
Asociaciones etiológicas	Síndrome metabólico, alcohol, carnes, diuréticos	Hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipomagnesemia
Manejo de crisis aguda	Colchicina 1+0.5mg, AINEs o Prednisona	AINEs, corticoides intraarticulares o sistémicos
Terapia hipouricemiante crónica	Alopurinol (titulado) + Colchicina profilaxis	No aplica terapia de disolución; AINEs si recidivas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	GOTA (URATO MONOSÓDICO)	CONDROCALCINOSIS (PIROFOSFATO)	TRAMPA EN EL EXAMEN
Hallazgo radiológico	Erosiones en sacabocado (Martel)	Calcificación lineal de meniscos	La gota no tiene osteopenia; pseudogota tiene meniscos blancos

REGLA DE ORO — **Urato: aguja negativa amarilla** — Birrefringencia intensamente negativa

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **14–17** (pág. 10) · solucionario págs. 23–24.

Clase 9.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.004 Artrosis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Radiografía de columna y articulaciones · Factores de riesgo de artrosis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El dolor de la artrosis es típicamente MECÁNICO**: aumenta con el uso/deambulación y alivia en reposo.
- **La rigidez matinal es breve**: dura menos de **15 a 30 minutos**.
- **Afectación clásica en manos**: Nódulos de Heberden en IFD, Nódulos de Bouchard en IFP y Rizartrosis en 1ra CMC.
- La artrosis típicamente RESPETA las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) y muñecas.
- **Los 4 signos radiológicos cardinales son**: pinzamiento articular asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas.
- **Tratamiento de primera línea**: medidas no farmacológicas (baja de peso, kinesiología) + AINEs tópicos / Paracetamol.



NÓDULOS DE HEBERDEN
Manual CTO Reumatología 14.ª ed., p. 64

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: ARTROSIS / OSTEOARTRITIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

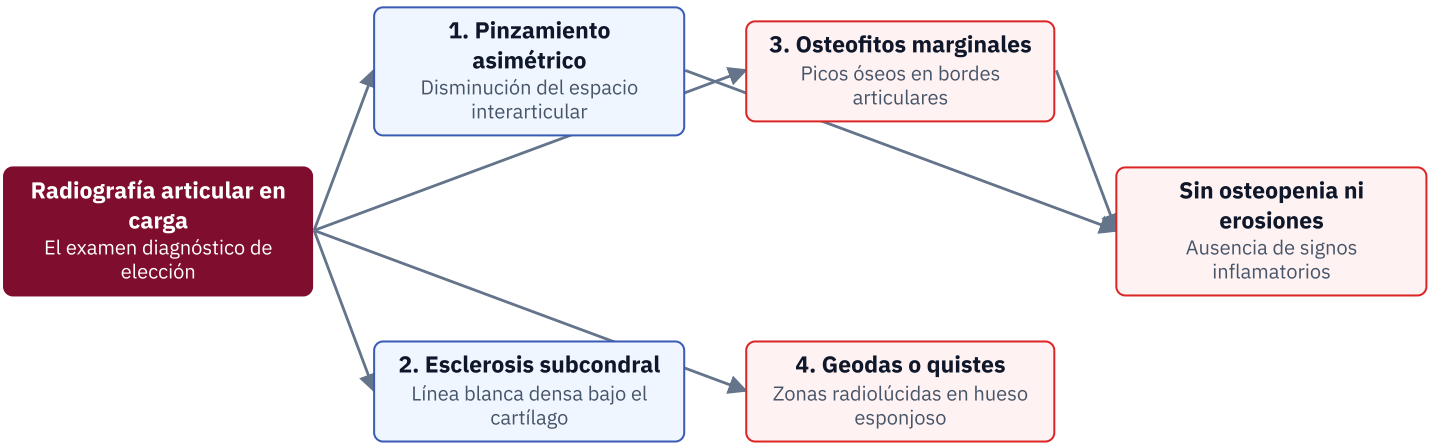


TABLA 9.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: ARTROSIS VS ARTRITIS REUMATOIDE

PARÁMETRO	ARTROSIS / OSTEOARTRITIS	ARTRITIS REUMATOIDE (AR)
Naturaleza de la enfermedad	Degenerativa / biomecánica del cartílago	Autoinmune inflamatoria de membrana sinovial
Tipo de dolor	Mecánico (empeora con uso, alivia en reposo)	Inflamatorio (peor en reposo, alivia con movimiento)
Rigidez matinal	Breve (< 15 a 30 minutos)	Prolongada (> 45 a 60 minutos)
Articulaciones en mano	IFD (Heberden), IFP (Bouchard), 1ra CMC	MCF, IFP, muñecas (RESPETA típicamente IFD)
Consistencia de tumefacción	Dura, ósea (osteofitos)	Blanda, pastosa, fluctuante (sinovitis)
Signos radiológicos	Pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis	Osteopenia periarticular, erosiones simétricas marginales
Laboratorio sistémico	VHS y PCR normales, FR y Anti-CCP negativos	VHS y PCR elevadas, FR y Anti-CCP positivos (80%)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	ARTROSIS / OSTEOARTRITIS	ARTRITIS REUMATOIDE	TRAMPA HABITUAL
Tratamiento de primera línea	Paracetamol y medidas físicas no farmacológicas	Metotrexato semanal (FARME) precoz	Iniciar antiinflamatorios en paciente con insuficiencia cardíaca

REGLA DE ORO **Dolor mecánico que cede en reposo** — Rigidez matinal menor a 30 minutos

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 9.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

9.5 Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.143 Artritis idiopática juvenil — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Poliartritis

LO QUE TE PREGUNTAN

- AIJ se define como artritis de causa desconocida de **≥ 6 semanas** de duración en menores de **16 años**.
- El subtipo oligoarticular (**≤ 4 articulaciones**) es el más frecuente y afecta a niñas de **2-4 años** en grandes articulaciones.
- AIJ oligoarticular con ANA (+) confiere un altísimo riesgo de UVEÍTIS ANTERIOR CRÓNICA ASINTOMÁTICA.
- Todo niño con sospecha de AIJ oligoarticular requiere examen oftalmológico urgente con lámpara de hendidura.
- La Enfermedad de Still del adulto se caracteriza por fiebre cotidiana vespertina > **39 °C**, artritis y rash asalmonado evanescente.



EXANTEMA ASALMONADO
Manual AMIR Reumatología, p. 57

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: AIJ Y ENFERMEDAD DE STILL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

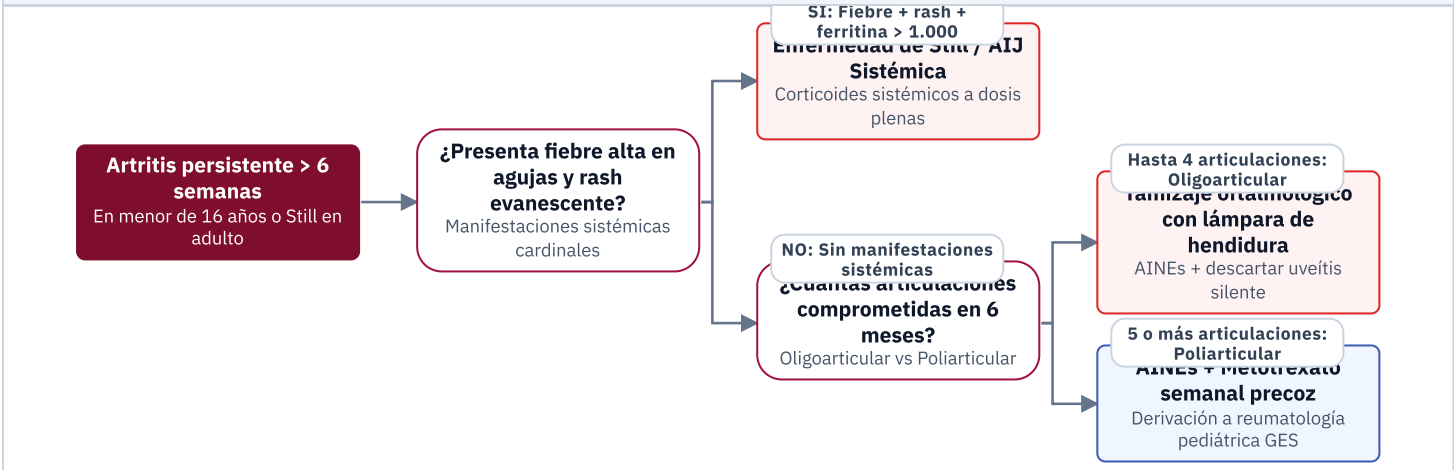


TABLA 9.5 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE YAMAGUCHI PARA ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO

CATEGORÍA DE CRITERIOS	MANIFESTACIONES ESPECÍFICAS
Criterios Mayores (se requieren ≥ 2)	1) Fiebre ≥ 39 °C intermitente de ≥ 1 semana de duración
	2) Artralgias o artritis de ≥ 2 semanas de evolución
	3) Exantema salmón macular o máculopapular no pruriginoso coincidente con la fiebre
	4) Leucocitosis ≥ 10.000/mm³ con ≥ 80% de granulocitos polimorfonucleares
Criterios Menores	1) Faringitis u odinofagia no purulenta
	2) Linfadenopatías y/o esplenomegalia
	3) Elevación de transaminasas hepáticas (GOT/GPT) y/o LDH
	4) Factor Reumatoide y ANA negativos por técnicas estándar
Criterio Excluyente	Exclusión estricta de infecciones bacterianas/virales, neoplasias (linfoma) y otras vasculitis

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CATEGORÍA	CRITERIO ESPECÍFICO	DETALLE SEMIOLÓGICO	IMPORTANCIA EUNACOM
Criterio Mayor	Fiebre ≥ 39 °C intermitente	Patrón cotidiano en agujas ≥ 1 semana	Diferencia de fiebres sépticas continuas
Criterio Mayor	Rash macular asalmonado	Evanescente, no pruriginoso, con la fiebre	Aparece durante el alza térmica y desaparece
Criterio Menor	ANA (-) y Factor Reumatoide (-)	Seronegatividad autoinmune clásica	Si los ANA o FR son positivos, descarta Still

REGLA DE ORO **Niña pequeña con ANA positivos** — Riesgo de uveítis anterior crónica silente

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Reumatología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 9.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

9.6 Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

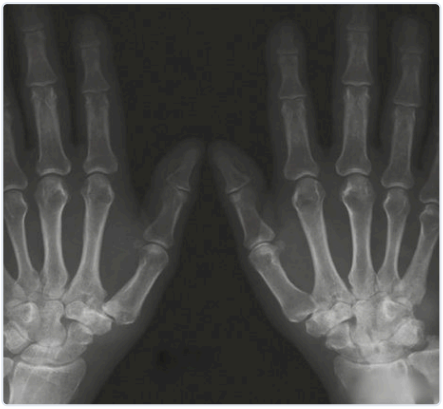
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.003 Artritis reumatoídea — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Poliartritis · Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA)

LO QUE TE PREGUNTAN

- La AR es una poliartritis simétrica aditiva que compromete muñecas, MCF e IFP.
- La AR RESPETA clásicamente las interfalángicas distales (IFD) y el esqueleto axial lumbar/dorsal.
- La única región vertebral afectada por AR es la columna cervical (riesgo vital de subluxación atloaxoidea C1-C2).
- Rigidez matinal prolongada mayor a **45-60 minutos** es el síntoma cardinal de actividad inflamatoria.
- **Criterios ACR/EULAR 2010**: puntaje **≥ 6 de** 10 puntos confirma el diagnóstico.
- El Anti-CCP posee una especificidad del **96-98%** para AR y predice enfermedad erosiva agresiva.



EROSIONES EN LAS MANOS
Manual CTO Reumatología 14.ª ed., p. 27

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO: ARTRITIS REUMATOIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

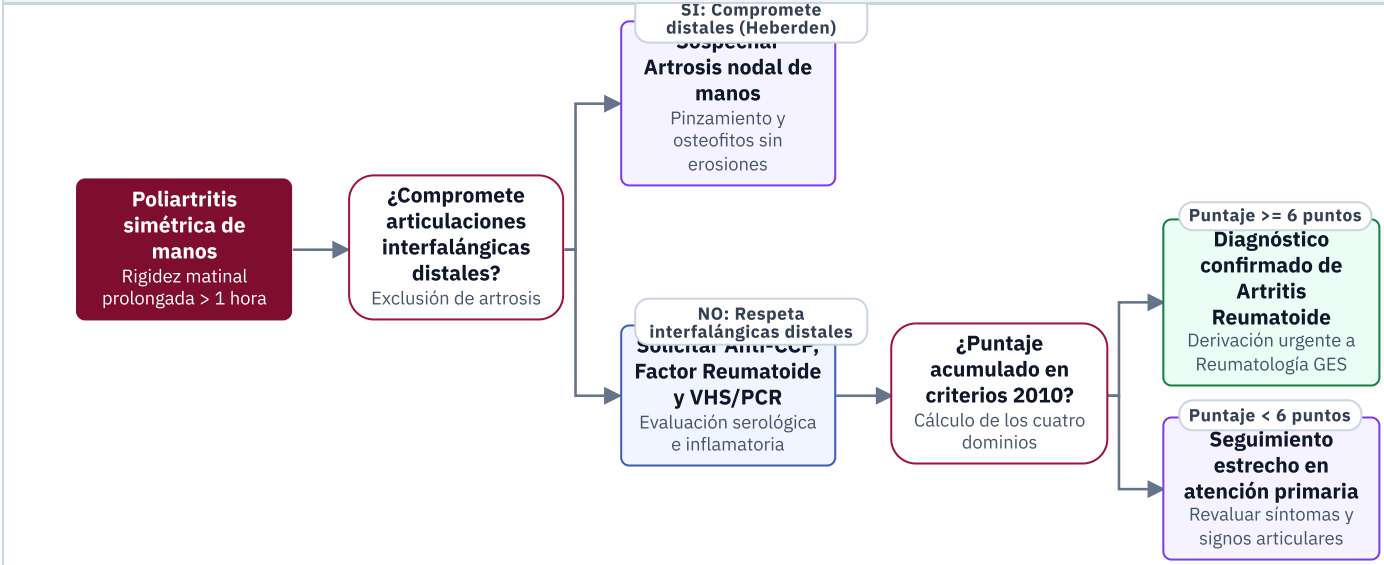


TABLA 9.6 · DESGLOSE DEL PUNTAJE DIAGNÓSTICO ACR/EULAR 2010 PARA ARTRITIS REUMATOIDE

CATEGORÍA DE CRITERIOS	HALLAZGOS ESPECÍFICOS	PUNTAJE ASIGNADO
Compromiso Articular	1 articulación grande / mediana afectada	0 puntos
	2 – 10 articulaciones grandes / medianas afectadas	1 punto
	1 – 3 articulaciones pequeñas afectadas	2 puntos
	4 – 10 articulaciones pequeñas afectadas	3 puntos
	> 10 articulaciones afectadas (al menos 1 pequeña)	5 puntos
Serología (FR / Anti-CCP)	FR y Anti-CCP negativos	0 puntos
	FR o Anti-CCP positivo a títulos bajos (≤ 3x VN)	2 puntos
	FR o Anti-CCP positivo a títulos ALTOS (> 3x VN)	3 puntos
Reactantes de Fase Aguda	VHS y PCR normales	0 puntos
	VHS o PCR anormalmente elevadas	1 punto
Duración de Síntomas	Duración < 6 semanas	0 puntos
	Duración ≥ 6 semanas	1 punto

REGLA DE ORO **MCF, IFP y muñecas simétricas** — Rigidez matinal prolongada mayor a 1 hora

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **2, 20–23** (págs. 8, 10–11) · solucionario págs. 21, 25.

Clase 9.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

9.7 Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.003 Artritis reumatoídea — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Metotrexato es el fármaco modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea indiscutido en Artritis Reumatoide.
- El metotrexato se prescribe SIEMPRE en dosis SEMANAL (**15 a 25 mg**/semana), NUNCA diaria.
- Es obligatorio prescribir Ácido Fólico (**5 a 10 mg** semanales) a las **24-48 horas** del MTX para reducir toxicidad digestiva y hepática.
- El metotrexato está absolutamente contraindicado en el embarazo por ser teratogénico y abortivo.
- Los corticoides a dosis bajas (**≤ 7.5-10 mg**/día) se usan como terapia de puente inicial y deben retirarse gradualmente.
- **REGLA DE ORO**: Antes de iniciar cualquier terapia biológica (Anti-TNF) es MANDATORIO descartar Tuberculosis Latente (PPD/IGRA + Rx tórax).
- Ante PPD **≥ 5 mm** o IGRA positivo se debe iniciar Isoniazida **300 mg**/día por **9 meses**, difiriendo el biológico al menos **1 mes**.

ALGORITMO · ALGORITMO TERAPÉUTICO: ARTRITIS REUMATOIDE

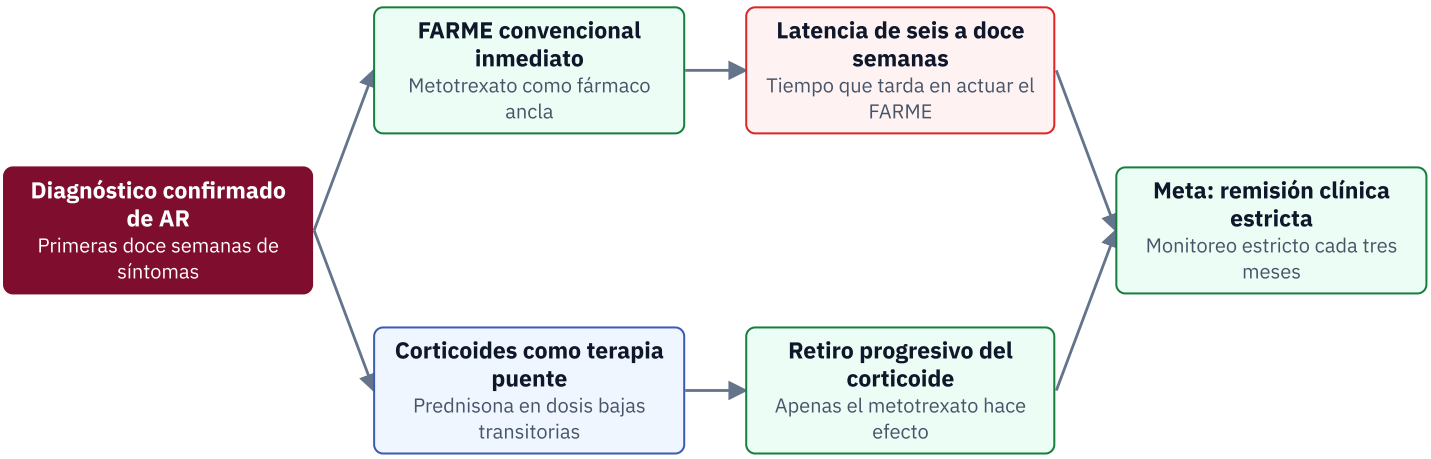


TABLA 9.7 · PERFIL COMPARATIVO DE FARME SINTÉTICOS EN ARTRITIS REUMATOIDE

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	DOSIS HABITUAL	TOXICIDAD PRINCIPAL	MONITOREO OBLIGATORIO
Metotrexato (MTX)	Antagonista del folato / adenosina	15 – 25 mg SEMANAL VO o SC	Hepatotoxicidad, citopenias, neumonitis	Hemograma y transaminasas cada 1-3 meses + Ácido Fólico
Leflunomida	Inhibidor síntesis de pirimidinas	20 mg / día oral	Diarrea, hipertensión, alopecia, hepatopatía	Presión arterial, hemograma y transaminasas
Sulfasalazina	Modulación citoquinas / prostaglandinas	2 – 3 g / día oral	Molestias GI, erupción cutánea, neutropenia	Hemograma y perfil hepático periódico
Hidroxicloroquina	Inhibición de presentación antigénica	200 – 400 mg / día (≤5mg/kg/d)	Toxicidad retiniana (maculopatía en ojo de buey)	Fondo de ojo y campo visual anual tras 5 años
Prednisona (Puente)	Inhibición transcripcional NF-kB	5 – 10 mg / día oral (transitorio)	Osteoporosis, síndrome de Cushing, diabetes	Densitometría ósea, glicemia, presión arterial

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

FÁRMACO	DOSIS Y VÍA HABITUAL	EFECTO ADVERSO CARDINAL	REGLA DE ORO EUNACOM
Terapia Biológica (Anti-TNF)	Subcutánea o endovenosa periódica	Reactivación de infecciones latentes	Descartar siempre Tuberculosis con PPD o IGRA y radiografía antes de iniciar

REGLA DE ORO **Fallo a dos FARME convencionales** — Incluyendo metotrexato en dosis plenas

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **24–27** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

Clase 9.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

9.8 Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta · Enfermedad paradigmática del tejido conectivo y patología GES

1.11.1.014 Lupus eritematoso sistémico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA)

LO QUE TE PREGUNTAN

- El criterio de entrada OBLIGATORIO según EULAR/ACR 2019 es ANA (+) **≥ 1**:80 en células HEp-2.
- Si los ANA son negativos por técnica estándar, el paciente NO puede clasificarse como LES.
- El eritema malar lúpico se caracteriza patognomónicamente por RESPETAR los surcos nasogenianos.
- El Anti-Smith (Sm) es el anticuerpo MÁS ESPECÍFICO de LES (> **99%**).
- El Anti-dsDNA se correlaciona directamente con la actividad inflamatoria y el riesgo de nefritis lúpica.
- El descenso conjunto de C3 y C4 (hipocomplementemia) traduce consumo por brote lúpico activo.
- La Artropatía de Jaccoud en el lupus es una deformidad articular reductible pasivamente que NO produce erosiones.



ERITEMA MALAR
Manual CTO Reumatología 14.ª ed., p. 81

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO BASAL: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

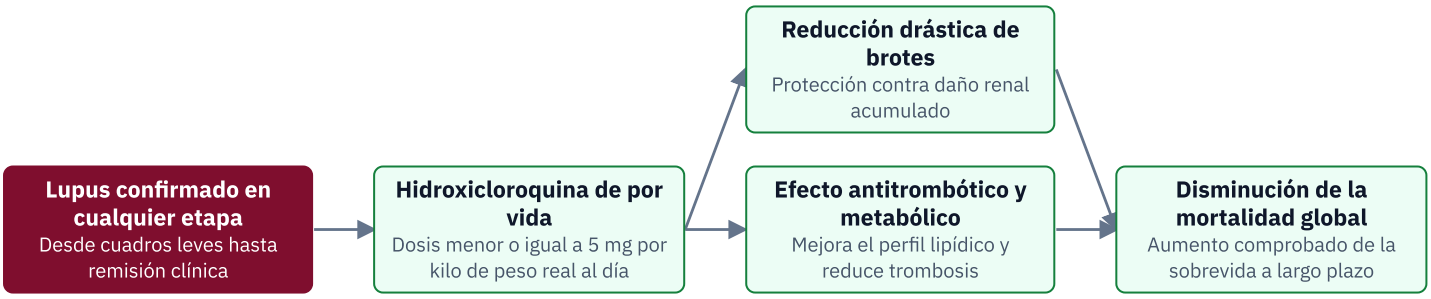


TABLA 9.8 · SIGNIFICADO CLÍNICO DE LOS AUTOANTICUERPOS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

ANTICUERPO	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	CORRELACIÓN CLÍNICA Y UTILIDAD
ANA (Antinucleares)	> 98%	~80%	Criterio de entrada obligatorio; excelente valor predictivo negativo
Anti-dsDNA (Doble hebra)	60 – 70%	> 95%	Marcador de actividad lúpica y predictor directo de Nefritis Lúpica
Anti-Smith (Sm)	20 – 30%	> 99%	El más específico de LES; confirma diagnóstico indudable
Anti-Ro (SSA)	30 – 40%	Inespecífico	Lupus cutáneo subagudo, fotosensibilidad y Bloqueo AV congénito neonatal
Anti-La (SSB)	15 – 20%	Inespecífico	Suele coexistir con Anti-Ro; menor riesgo de nefritis
Anti-Histona	50 – 70%	Baja en LES	Positivo en > 95% del Lupus Inducido por Drogas (fármacos)
Anti-RNP (U1-RNP)	30%	Inespecífico	Típico de Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) y fenómeno de Raynaud

REGLA DE ORO **ANA mayor a 1:80 de entrada** — Sensibilidad máxima; si es negativo no es lupus

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **28–32** (págs. 11–12) · solucionario págs. 27–28.

Clase 9.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

9.9 Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.09.1.006 **Glomerulopatía lúpica** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Lupus eritematoso sistémico

LO QUE TE PREGUNTAN

- La nefritis lúpica afecta hasta al **50%** de los pacientes con LES y es su principal causa de morbimortalidad.
- La biopsia renal es el patrón de oro y está indicada formalmente ante proteinuria **≥ 0.5 g/24h** o sedimento activo.
- La Clase IV (Proliferativa Difusa) es la más frecuente, más agresiva y de peor pronóstico si no se trata a tiempo.
- La Clase IV cursa típicamente con sedimento activo (cilindros hemáticos), hipocomplementemia severa y anti-dsDNA elevado.
- La Clase V (Membranosa) cursa con síndrome nefrótico puro con alto riesgo trombótico.
- El tratamiento de inducción de nefritis proliferativa requiere pulsos de Metilprednisolona EV + Micofenolato Mofetilo (o Ciclofosfamida).



HEMATÍES DISMÓRFICOS
Manual CTO Nefrología, p. 33

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO Y MANEJO: NEFRITIS LÚPICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

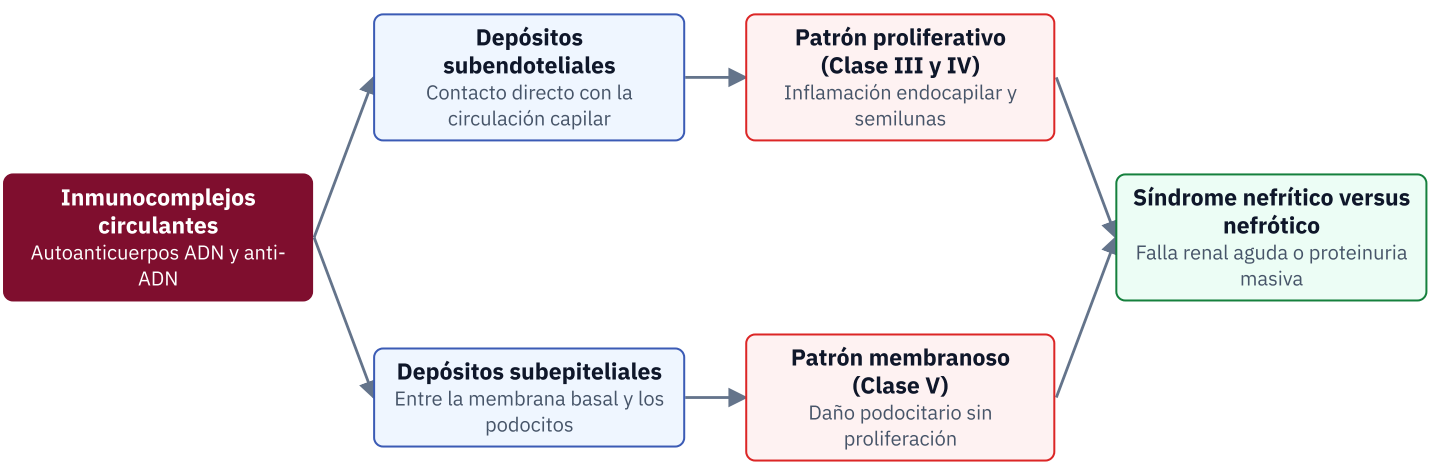


TABLA 9.9 · CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA ISN/RPS DE NEFRITIS LÚPICA Y MANEJO CLÍNICO

CLASE HISTOLÓGICA	PATOLOGÍA RENAL DOMINANTE	PRESENTACIÓN CLÍNICA TÍPICA	ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN
Clase I (Mesangial mínima)	Glomérulos normales en MO; depósitos mesangiales en IF	Sedimento normal o microhematuria leve	Manejo basal con Hidroxicloroquina
Clase II (Proliferativa mesangial)	Hipercelularidad mesangial pura	Microhematuria y proteinuria < 1 g/24h	Corticoides orales solo si síntomas extra-renales
Clase III (Proliferativa focal)	Proliferación endo/extracapilar en < 50% de glomérulos	Síndrome nefrítico, proteinuria, hipertensión	Pulsos Metilprednisolona + Micofenolato o Ciclofosfamida
Clase IV (Proliferativa difusa)	Proliferación en ≥ 50% glomérulos; asas en alambre	Síndrome nefrítico-nefrótico severo, falla renal aguda	Pulsos Metilprednisolona + MMF (2-3g/d) o Ciclofosfamida
Clase V (Membranosa)	Depósitos subepiteliales; engrosamiento de pared	Síndrome nefrótico florido puro, riesgo de TVP	Prednisona + Micofenolato o Tacrolimus + IECA/ARA-II
Clase VI (Esclerosante avanzada)	Esclerosis global en ≥ 90% de los glomérulos	Insuficiencia renal crónica avanzada, uremia	Preparación para Terapia de Reemplazo Renal / Diálisis

REGLA DE ORO **Biopsia ante proteinuria o sedimento activo** — Mayor a 0.5 g al día o cilindros hemáticos

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **33–36** (pág. 12) · solucionario págs. 28–29.

Clase 9.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

9.10 Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

6.01.1.016 Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Lupus eritematoso sistémico

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Lupus Discoide se caracteriza por placas con hiperqueratosis, tapones foliculares y atrofia central cicatricial.
- En el cuero cabelludo, el lupus discoide provoca alopecia cicatricial permanente irreversible.
- El Lupus Cutáneo Subagudo cura SIN dejar cicatriz y se asocia intensamente a anticuerpos Anti-Ro (SSA).
- Las madres con Anti-Ro (+) tienen riesgo de tener recién nacidos con Bloqueo Auriculoventricular Congénito completo.
- El Lupus Inducido por Drogas es causado típicamente por Hidralazina, Procainamida, Isoniazida y anti-TNF.

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: VARIANTES CUTÁNEAS Y LUPUS INDUCIDO POR DROGAS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 9.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO VS LUPUS INDUCIDO POR DROGAS

CARACTERÍSTICA	LUPUS SISTÉMICO (LES IDIOPÁTICO)	LUPUS INDUCIDO POR DROGAS (FARMACOLÓGICO)
Sexo predominante	Mujeres jóvenes en edad fértil (9:1)	Distribución similar en ambos sexos; mayor en adultos mayores
Compromiso renal (Nefritis)	Muy frecuente (hasta 50%), grave (Clase IV)	Excepcional / Prácticamente ausente
Compromiso neuropsiquiátrico	Frecuente (convulsiones, psicosis, delirium)	Excepcional / Prácticamente ausente
Anticuerpos Anti-Histona	Positivos en 50 – 60%	Positivos en > 95% de los casos
Anticuerpos Anti-dsDNA	Positivos en 60 – 70% (marcador de actividad)	Típicamente NEGATIVOS
Anticuerpos Anti-Smith (Sm)	Positivos en 20 – 30% (muy específico)	Típicamente NEGATIVOS
Niveles de Complemento (C3/C4)	Frecuentemente DISMINUIDOS (consumo en brotes)	Típicamente NORMALES

TRAMPAS EUNACOM

CONDICIÓN	LESIÓN CUTÁNEA TÍPICA	SEROLOGÍA DOMINANTE	COMPROMISO RENAL Y TRATAMIENTO
LES Sistémico Clásico	Eritema malar que respeta surcos nasogenianos	ANA positivos (>98%) · Anti-Sm específico · Anti-ADN alto	Muy frecuente y grave (Clase IV) · Hidroxicloroquina de por vida
Lupus Discoide Crónico	Placas eritematosas con hiperqueratosis y atrofia	ANA frecuentemente negativos (70%)	Compromiso renal ausente · Fotoprotección, corticoides locales e hidroxicloroquina

REGLA DE ORO **Ausencia de nefritis lúpica** — Sedimento de orina y creatinina normales

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, pregunta **19** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 9.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta · Trombofilia autoinmune de mayor relevancia clínica y obstétrica en EUNACOM

1.11.1.021 **Síndrome antifosfolípidos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Trombofilias

LO QUE TE PREGUNTAN

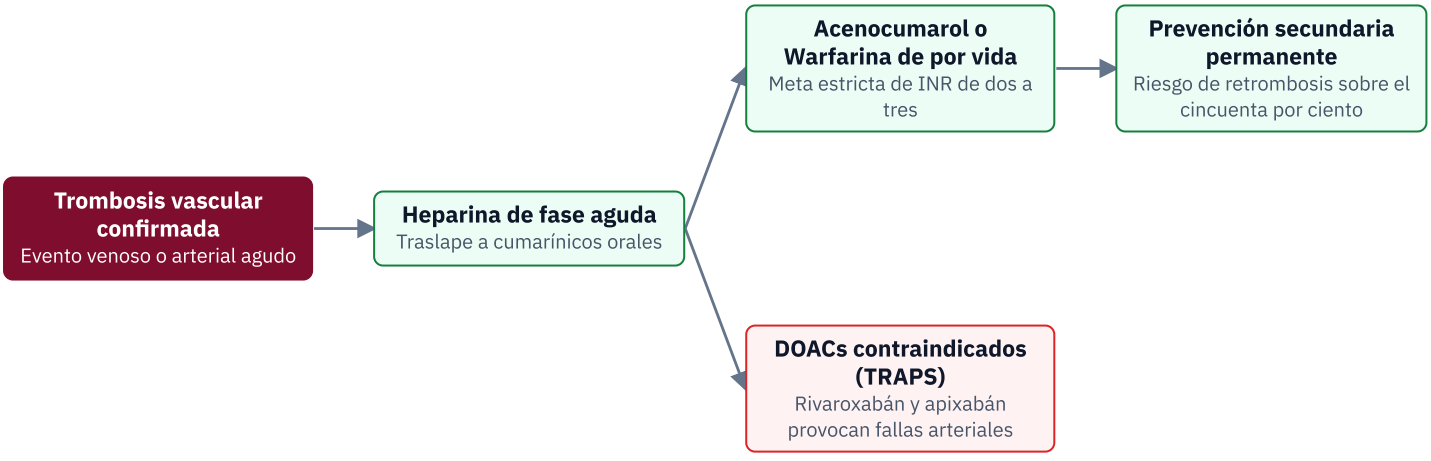
- El SAF requiere al menos 1 criterio clínico (trombosis o morbilidad obstétrica) y 1 de laboratorio.
- Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de **12 semanas**.
- El Anticoagulante Lúpico alarga el TTPK in vitro, pero es el marcador de mayor riesgo trombótico in vivo.
- En trombosis venosa por SAF, el tratamiento de elección es Acenocumarol o Warfarina (INR 2.0 a 3.0) de por vida.
- Los DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) están CONTRAINDICADOS en pacientes con SAF de triple positividad.
- En SAF obstétrico sin trombosis previa, el tratamiento es AAS **100 mg**/día + HBPM profiláctica (Enoxaparina **40 mg**/d).
- Los cumarínicos son teratogénicos y están absolutamente contraindicados durante el embarazo.



LIVEDO RETICULARIS
Manual AMIR Reumatología, p. 39

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **37–43** (págs. 12–13) · solucionario págs. 29–30.

Clase 9.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 9.11 · CRITERIOS CLASIFICATORIOS DE SYDNEY PARA SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF)

CATEGORÍA	CRITERIOS ESPECÍFICOS	CONDICIÓN MANDATORIA
Criterio Clínico: Trombosis	≥ 1 episodio de trombosis arterial, venosa o microvascular en cualquier tejido	Confirmada objetivamente por imagen o biopsia sin vasculitis
Criterio Clínico: Obstétrico 1	≥ 1 muerte fetal tardía inexplicable de feto normal a partir de las 10 semanas	Morfología fetal normal por ecografía o autopsia
Criterio Clínico: Obstétrico 2	≥ 1 parto prematuro de recién nacido normal antes de la semana 34	Debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria
Criterio Clínico: Obstétrico 3	≥ 3 abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de la semana 10	Descartadas causas anatómicas, endocrinas o cromosómicas
Criterio de Laboratorio 1	Anticoagulante Lúpico (AL) positivo en plasma según guías ISTH	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia
Criterio de Laboratorio 2	Anticuerpos Anticardiolipina (aCL) IgG o IgM a títulos moderados/altos (>40 U)	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia
Criterio de Laboratorio 3	Anticuerpos Anti-Beta-2-Glicoproteína I IgG o IgM en títulos > percentil 99	Confirmar en ≥ 2 tomas con ≥ 12 semanas de diferencia

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO	OBJETIVO PRIMARIO	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	REGLA DE ORO EUNACOM
Trombosis venosa por SAF	Prevención secundaria de TVP o TEP	Acenocumarol o Warfarina (meta INR 2.0 a 3.0)	Anticoagulación INDEFINIDA de por vida · DOACs formalmente contraindicados
Trombosis arterial (ej. ACV)	Prevención de nuevos infartos	Cumarínicos (INR 2-3) más Aspirina 100 mg/día	Control agresivo de factores de riesgo cardiovascular y seguimiento hematológico
SAF Obstétrico sin trombosis	Prevenir muerte fetal y preeclampsia	Aspirina 100 mg/día más Enoxaparina 40 mg/día SC	Iniciar aspirina preconcepcional y heparina con saco intrauterino hasta 6 semanas postparto
SAF Obstétrico con trombosis	Prevenir trombosis materna y pérdida fetal	Aspirina 100 mg/día más Enoxaparina a dosis terapéutica plena	Cumarínicos prohibidos en embarazo por teratogenia · Retomar warfarina en puerperio

REGLA DE ORO **Anticoagulante lúpico en plasma** — Pruebas funcionales según guías ISTH

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Síndrome Antifosfolípido (SAF) es una trombofilia autoinmune adquirida de alta morbilidad. El EUNACOM examina con regularidad la paradoja del Anticoagulante Lúpico (prolonga el TTPK in vitro pero causa trombosis in vivo), la necesidad estricta de confirmar los anticuerpos con 12 semanas de diferencia, el esquema obstétrico protector con AAS y heparina de bajo peso molecular, y la contraindicación formal de los nuevos anticoagulantes orales directos (DOACs) en pacientes con triple positividad.

TABLA 9.11.B · MONITOREO Y CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS CRÍTICAS EN SAF

FÁRMACO	VÍA Y DOSIS HABITUAL	MONITOREO DE LABORATORIO	REGLAS DE SEGURIDAD EUNACOM
Acenocumarol / Warfarina	Oral, ajustada a INR	INR mensual (Meta 2.0 a 3.0)	Teratogénicos: suspender antes de semana 6 de embarazo
Enoxaparina (HBPM)	Subcutánea (40mg/d o 1mg/kg c/12h)	Recuento de plaquetas (riesgo TIH) y antifactor Xa si ERC	No requiere monitoreo de rutina de coagulación; segura en gestación
Ácido Acetilsalicílico	100 mg / día oral	Clínico (tolerancia digestiva)	Iniciar preconcepcional en mujeres con pérdidas previas
DOACs (Rivaroxabán/Apixabán)	Oral dosis fija	No disponible en rutina	CONTRAINDICADOS en SAF con triple positividad por falla arterial

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **37–43** (págs. 12–13) · solucionario págs. 29–30.

Clase 9.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.009 **Esclerosis sistémica progresiva** Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

También: Enfermedades del intersticio pulmonar · Hipertensión pulmonar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Esclerosis Difusa presenta afección cutánea proximal al codo y tronco, Anti-Scl-70 y alto riesgo de EPID y crisis renal.
- La Esclerosis Limitada (CREST) se asocia a Anticentrómero (ACA) y riesgo tardío de Hipertensión Pulmonar (HTP Grupo 1).
- **El Síndrome de CREST comprende**: Calcinosis, Raynaud, Esofagopatía, Sclerodactilia y Telangiectasias.
- La principal causa de muerte en esclerodermia difusa es la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID).
- La Crisis Renal Esclerodérmica se manifiesta como hipertensión maligna de inicio brusco y falla renal microangiopática.
- El tratamiento de ELECCIÓN en la Crisis Renal Esclerodérmica son los IECA (Captopril oral a dosis plenas).



ESCLERODACTILIA
Manual AMIR Reumatología, p. 99

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: ESCLEROSIS SISTÉMICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

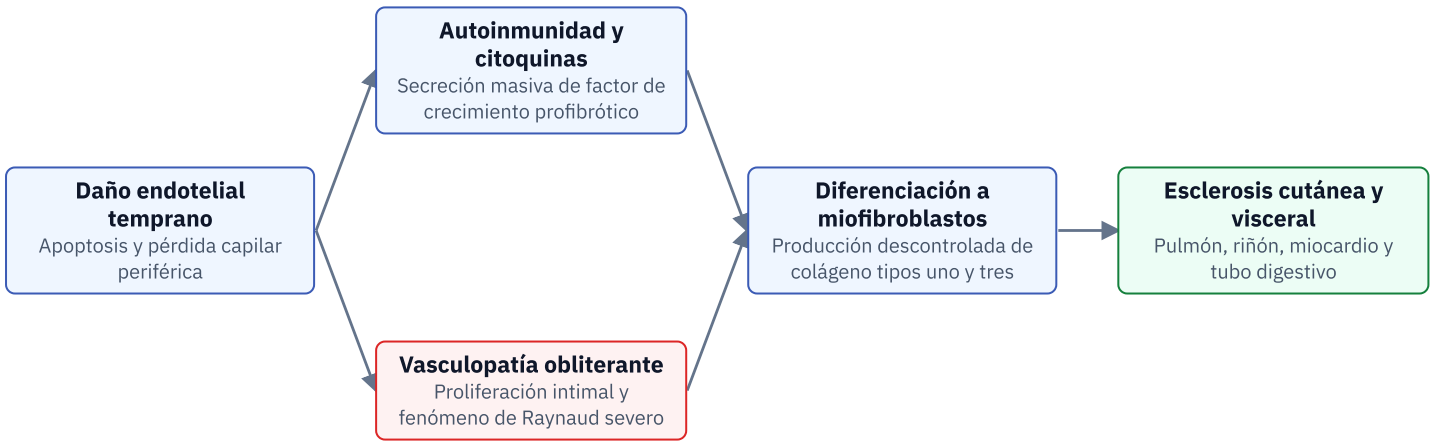


TABLA 9.12 · DIFERENCIAS CARDINALES: ESCLEROSIS SISTÉMICA CUTÁNEA DIFUSA VS LIMITADA (CREST)

CARACTERÍSTICA	FORMA CUTÁNEA DIFUSA (ESCD)	FORMA CUTÁNEA LIMITADA (CREST / ESCL)
Extensión cutánea	Piel proximal a codos/rodillas, tronco y abdomen	Restringida a manos, pies, antebrazos distales y cara
Fenómeno de Raynaud	Inicio simultáneo o poco antes (< 1 año)	Precede por muchos años o décadas al daño cutáneo
Autoanticuerpo específico	Anti-Scl-70 (Topoisomerasa I) y Anti-ARN Pol III	Anticuerpos Anticentrómero (ACA) (> 70-80%)
Patrón ANA en IFI	Patrón Nucleolar	Patrón Anticentrómero
Afección pulmonar típica	Fibrosis Pulmonar Intersticial precoz (EPID)	Hipertensión Arterial Pulmonar tardía (HTP Grupo 1)
Complicación renal	Crisis Renal Esclerodérmica (10-15%)	Excepcional / Muy rara
Calcinosis y Telangiectasias	Poco frecuentes o leves	Muy prominentes y extensas (componente CREST)
Pronóstico global	Más sombrío; mayor mortalidad temprana	Mejor sobrevida a mediano plazo; riesgo de HTP tardía

REGLA DE ORO **Difusa: tronco, anti-Scl-70 y EPID** — Fibrosis pulmonar como principal causa de muerte

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **44–47** (págs. 13–14) · solucionario págs. 31–32.

Clase 9.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

Alta · Cuadros con signos cutáneos patognomónicos y alerta oncológica crucial en el examen

1.11.1.020 **Polimiositis, dermatomiositis** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis) · Mesenquimopatías

LO QUE TE PREGUNTAN

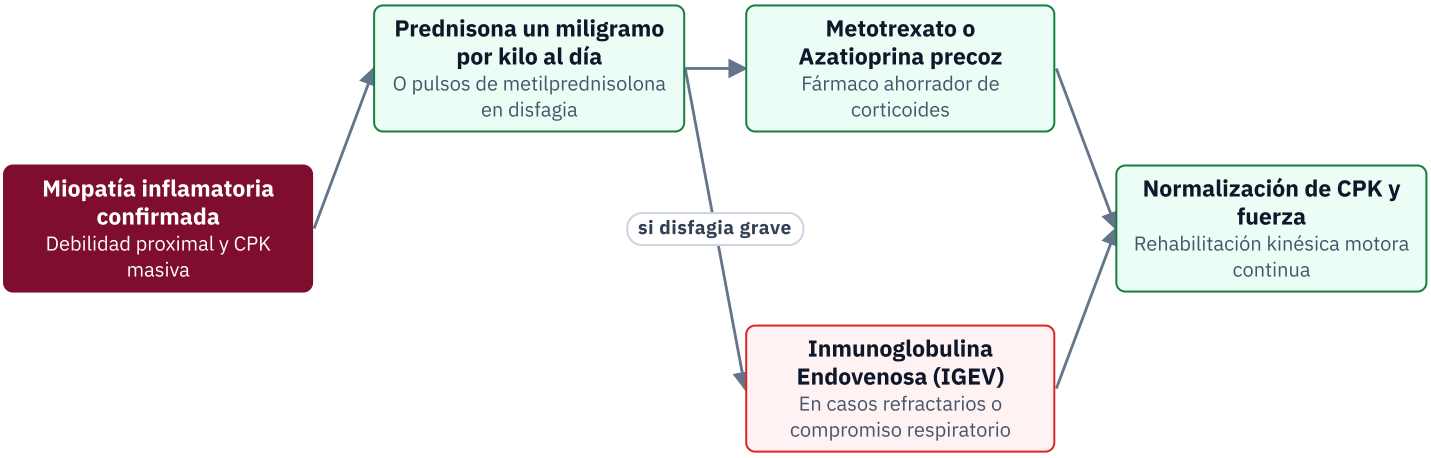
- Las miopatías inflamatorias cursan con debilidad muscular proximal simétrica y elevación masiva de CPK.
- Tanto la polimiositis como la dermatomiositis RESPETAN los músculos faciales y extraoculares.
- El eritema en heliotropo y las pápulas de Gottron son lesiones cutáneas patognomónicas de la Dermatomiositis.
- La histología de la dermatomiositis muestra atrofia perifascicular e infiltrado perimisial/perivascular por CD4+ y B.
- La polimiositis presenta infiltrado endomisial de linfocitos T CD8+ que invaden miofibras que expresan MHC-I.
- **El anticuerpo Anti-Jo-1 define el Síndrome Antisintetasa**: miositis, fibrosis pulmonar intersticial severa, Raynaud y manos de mecánico.
- **REGLA DE ORO**: Todo adulto con Dermatomiositis requiere un tamizaje exhaustivo de Neoplasia Oculta.



HELIOTROPO
Manual CTO Dermatología, p. 119

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: MIOPATÍAS INFLAMATORIAS AUTOINMUNES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **48–52** (pág. 14) · solucionario págs. 32–33.

Clase 9.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 9.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLIMIOSITIS VS DERMATOMIOSITIS

PARÁMETRO	POLIMIOSITIS (PM)	DERMATOMIOSITIS (DM)
Mecanismo inmunológico primario	Citotoxicidad celular directa por linfocitos T CD8+	Microangiopatía mediada por complemento e inmunocomplejos
Localización del infiltrado histológico	Endomisial (infiltración intrafascicular de fibras)	Perimisial y perivascular (en tabiques conjuntivos)
Lesión histopatológica característica	Invasión de miofibras no necróticas que expresan MHC-I	Atrofia perifascicular de las fibras musculares
Lesiones cutáneas patognomónicas	AUSENTES (enfermedad muscular pura)	PRESENTES: Heliotropo, Gottron, signo del chal
Asociación a neoplasia oculta	Leve a moderada (~10%)	Muy ALTA (25 – 30% en adultos mayores)
Población más afectada	Adultos > 20 años; rara en niños	Bimodal: Forma juvenil (5-14 años) y adultos (> 50 años)

TRAMPAS EUNACOM

PATOLOGÍA	MÚSCULOS OCULARES	LESIONES CUTÁNEAS	HALLAZGO CLAVE DE LABORATORIO
Polimiositis	ESTRICTAMENTE RESPETADOS	Ausentes (afección muscular pura)	Infiltrado endomisial CD8+ · CPK masiva (10 a 50x)
Dermatomiositis	ESTRICTAMENTE RESPETADOS	Heliotropo y pápulas de Gottron	Atrofia perifascicular · ALERTA: tamizaje de cáncer oculto
Miastenia Gravis	TÍPICAMENTE AFECTADOS (Ptosis / Diplopía)	Ausentes	Anticuerpos anti-receptor de acetilcolina · CPK NORMAL

REGLA DE ORO **Síndrome paraneoplásico en el adulto** — Riesgo máximo en mayores de cincuenta años

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las miopatías inflamatorias autoinmunes se manifiestan por debilidad de cinturas proximales y elevación masiva de CPK. La Dermatomiositis destaca por sus signos cutáneos patognomónicos (eritema en heliotropo y pápulas de Gottron). En el EUNACOM es un concepto capital recordar que hasta un 25-30% de las dermatomiositis en el adulto constituyen un síndrome paraneoplásico, obligando a un tamizaje tumoral exhaustivo inmediato.

TABLA 9.13.B · ESQUEMA FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

FASE TERAPÉUTICA	FÁRMACOS Y DOSIFICACIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	CRITERIO DE AJUSTE / RESPUESTA
Fase de Inducción Aguda	Prednisona 1 mg/kg/día oral (o Pulsos Metilprednisolona 1g EV x 3d)	4 a 8 semanas	Normalización de CPK y mejoría de fuerza muscular
Fase de Descenso y Ahorro	Iniciar Metotrexato 15-25 mg/semana o Azatioprina 2-3 mg/kg/d	Meses 2 a 12	Descenso gradual de prednisona hasta ≤ 5-10 mg/d
Manejo de Casos Refractarios	Inmunoglobulina Endovenosa (IGEV 2 g/kg total) o Rituximab	Ciclos mensuales	Falla de FARME o disfagia grave con riesgo aspirativo
Rehabilitación Física	Kinesioterapia pasiva precoz y activa supervisada	Continua	Prevenir contracturas articulares y atrofia por desuso

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **48–52** (pág. 14) · solucionario págs. 32–33.

Clase 9.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.14 Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.009 Esclerosis sistémica progresiva — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Las 3 fases del Raynaud son**: Palidez (vasoespasmo), Cianosis (estasis desoxigenada) y Rubor (reperfusión reactiva).
- El Raynaud Primario es simétrico, sin úlceras digitales, con ANA (-) y capilaroscopía normal.
- El Raynaud Secundario es asimétrico, con úlceras en pulpejos, ANA (+) y capilaroscopía con megacapilares.
- La capilaroscopía periungueal es el examen de elección para descartar conectivopatía subyacente.
- **Fármaco de primera línea para el Raynaud sintomático**: Calcioantagonistas dihidropiridínicos (Nifedipino oral).
- Están contraindicados los betabloqueadores y vasoconstrictores en pacientes con Raynaud.



FASE BLANCA
Manual CTO Reumatología 14.ª ed., p. 91

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO CLÍNICO: FENÓMENO DE RAYNAUD

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

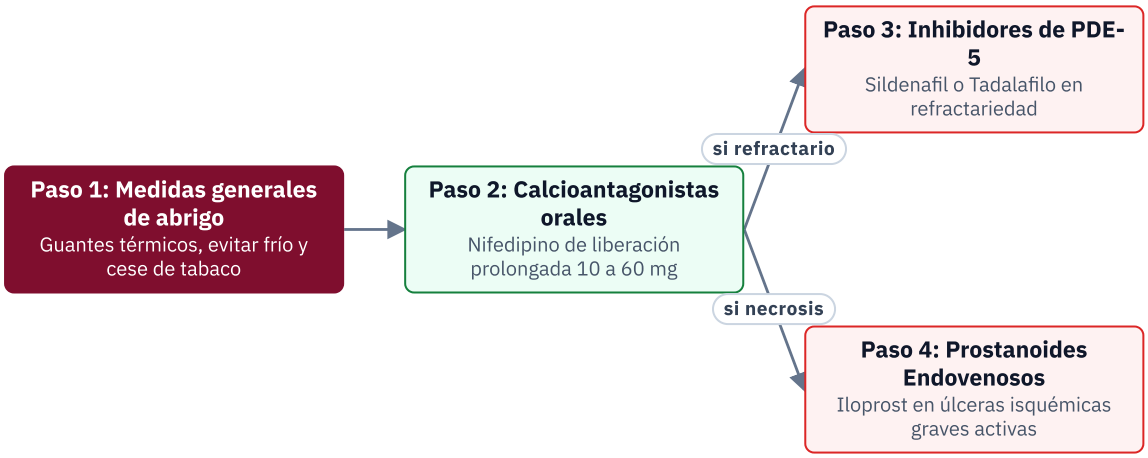


TABLA 9.14 · DIFERENCIAS CRÍTICAS ENTRE FENÓMENO DE RAYNAUD PRIMARIO Y SECUNDARIO

PARÁMETRO CLÍNICO / BIOLÓGICO	RAYNAUD PRIMARIO (ENFERMEDAD)	RAYNAUD SECUNDARIO (SÍNDROME)
Edad de inicio	Típicamente 15 – 30 años (mujeres jóvenes)	Típicamente > 30 – 40 años
Simetría	Estrictamente simétrico y bilateral	Frecuentemente asimétrico
Daño tisular trófico	AUSENTE (sin necrosis ni úlceras)	PRESENTE: Úlceras digitales dolorosas, cicatrices puntiformes
Autoanticuerpos (ANA)	Negativos (o títulos insignificantes)	POSITIVOS en títulos significativos (anti-Scl70, ACA, etc.)
Capilaroscopía periungueal	Normal (asas regulares en horquilla)	PATOLÓGICA (megacapilares, hemorragias, áreas avasculares)
Reactantes (VHS / PCR)	Estrictamente normales	Frecuentemente elevados
Etiología subyacente	Idiopático funcional	Esclerosis sistémica, LES, Sjögren, fármacos

REGLA DE ORO **Palidez, cianosis y rubor reactivo** — Vasoespasmo isquémico, estasis e hiperemia

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, pregunta **53** (pág. 14) · solucionario pág. 33.

Clase 9.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.022 **Síndrome de Sjögren** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome de ojo seco · Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA)

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada por xeroftalmia y xerostomía.
- El Test de Schirmer es patológico si la impregnación del papel filtro es < **5 mm** en **5 minutos**.
- **La biopsia de glándula salival menor es el estándar de oro**: muestra infiltrado focal **≥ 1 foco/4 mm²**.
- Los anticuerpos Anti-Ro (SSA) son positivos en **70-80%** y Anti-La (SSB) en **40-50%** de los pacientes.
- Los pacientes con Síndrome de Sjögren tienen un riesgo **40 veces** mayor de desarrollar Linfoma MALT.
- La EMTC combina características de Lupus, Esclerodermia y Polimiositis.



ROSA DE BENGALA
Kanski, Clinical Ophthalmology, p. 135

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: SÍNDROME SICCA Y SOSPECHA DE SJÖGREN O EMTC

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

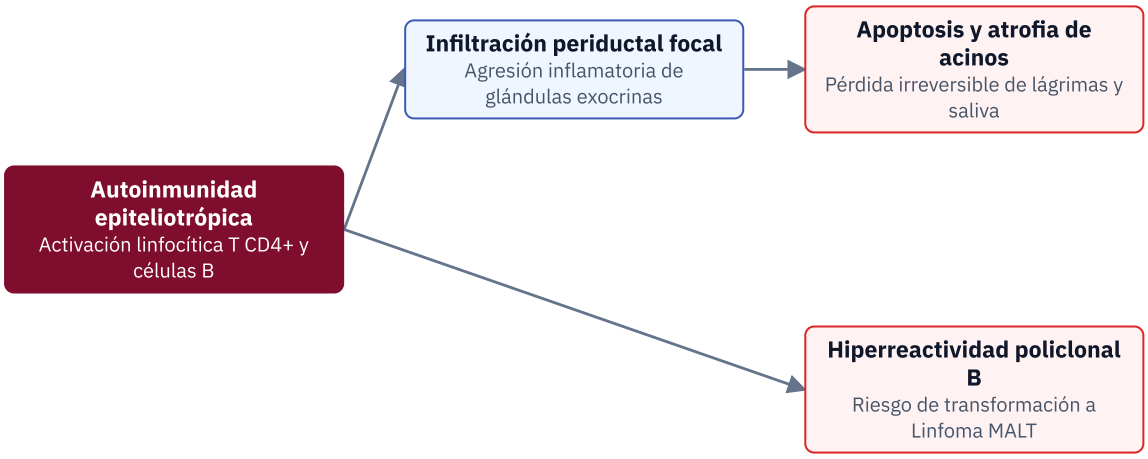


TABLA 9.15 · RESUMEN DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y MARCADORES: SJÖGREN VS EMTC

ENFERMEDAD	MANIFESTACIÓN GUÍA CARDINAL	PRUEBA DIAGNÓSTICA OBJETIVA	AUTOANTICUERPO CLAVE	COMPLICACIÓN MAYOR
Síndrome de Sjögren	Xeroftalmia (ojo seco) + Xerostomía (boca seca)	Test de Schirmer (<5mm/5min) y Biopsia labial (Focus Score ≥1)	Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB)	Linfoma No Hodgkin B (MALT en parótida)
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	Raynaud + Manos tumefactas (puffy fingers) + Miositis + Artritis	Biopsia muscular miopática y manometría esofágica	Anti-U1-RNP a títulos muy altos (>1:1.000)	Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PATOLOGÍA	MANIFESTACIÓN CARDINAL	ANTICUERPO CLAVE	COMPLICACIÓN DE MAYOR ALERTA
Lupus Eritematoso Sistémico	Eritema malar + Fotosensibilidad + Artritis	Anti-ADN doble hebra y Anti-Smith	Nefritis lúpica proliferativa difusa

REGLA DE ORO **Ojo seco, boca seca y test de Schirmer** — Test menor a cinco milímetros y biopsia salival con focos

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, pregunta **54** (pág. 14) · solucionario pág. 33.

Clase 9.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

9.16 Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

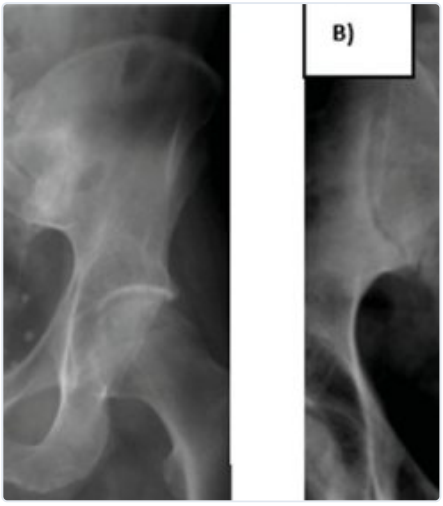
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.018 Pelviespondilopatías seronegativas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Lumbago mecánico · Columna dolorosa

LO QUE TE PREGUNTAN

- El dolor lumbar inflamatorio MEJORA con el ejercicio y EMPEORA con el reposo en cama.
- El dolor nocturno en la segunda mitad de la noche que obliga a levantarse es característico de inflamación axial.
- Los criterios ASAS exigen dolor crónico (> **3 meses**) en menores de **45 años** con al menos 4 de 5 parámetros cardinales.
- El dolor en nalgas alternante (en báscula) es la manifestación semiológica de la sacroilitis bilateral.
- **Las espondiloartritis son seronegativas**: Factor Reumatoide y ANA son constantemente negativos.
- La entesitis (inflamación del tendón de Aquiles o fascia plantar) es la lesión patológica distintiva.



SACROILITIS EN LA RX
Manual AMIR Reumatología, p. 79

ALGORITMO · ALGORITMO DE DIFERENCIACIÓN: LUMBAGO INFLAMATORIO VS MECÁNICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

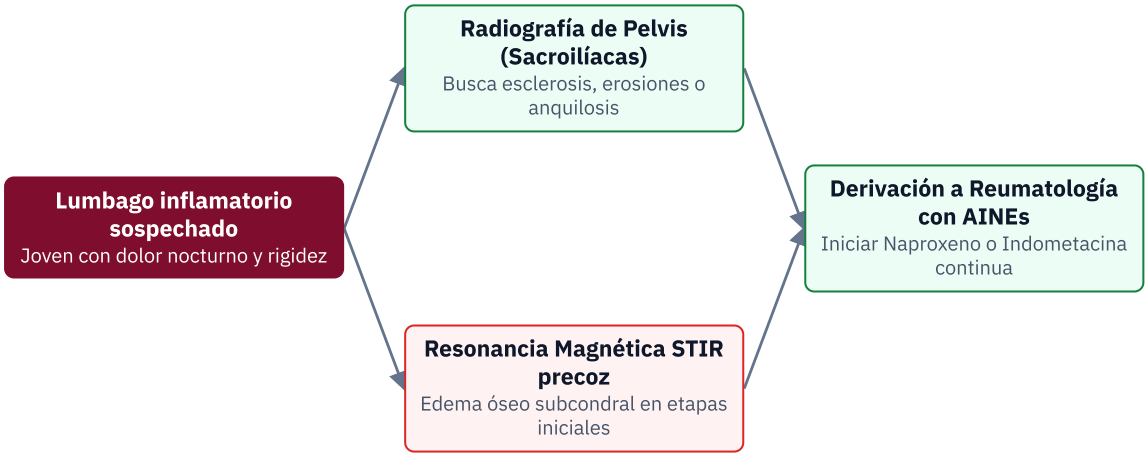


TABLA 9.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: LUMBAGO INFLAMATORIO VS MECÁNICO

PARÁMETRO CLÍNICO	LUMBAGO INFLAMATORIO (ESPONDILOARTROPATÍA)	LUMBAGO MECÁNICO COMÚN
Edad habitual de inicio	Menor de 45 años (típicamente 20 – 35 años)	Cualquier edad (pico entre 30 y 60 años)
Forma de inicio	Insidiosa, progresiva, sin desencadenante claro	Aguda o subaguda, frecuentemente tras esfuerzo físico
Efecto del ejercicio	MEJORA marcadamente con la actividad física	EMPEORA con el ejercicio y la deambulación
Efecto del reposo	EMPEORA con el reposo prolongado en cama	MEJORA o desaparece con el reposo en cama
Dolor nocturno	Frecuente en la 2da mitad de la noche; obliga a levantarse	Raro o ausente (salvo cambios posturales bruscos)
Rigidez matinal	Prolongada (superior a 30 – 60 minutos)	Breve (menor a 15 – 30 minutos)
Respuesta a AINEs	Espectacular y rápida (alivio > 75% en 24-48h)	Parcial o modesta
Dolor en nalgas	Alternante (en báscula: sacroilitis bilateral)	Unilateral o irradiado por dermatoma (ciática)

REGLA DE ORO **La prueba semiológica del movimiento** — El ejercicio alivia el dolor; el reposo en cama lo agrava

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **55–59** (págs. 14–15) · solucionario pág. 34.

Clase 9.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

9.17 Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

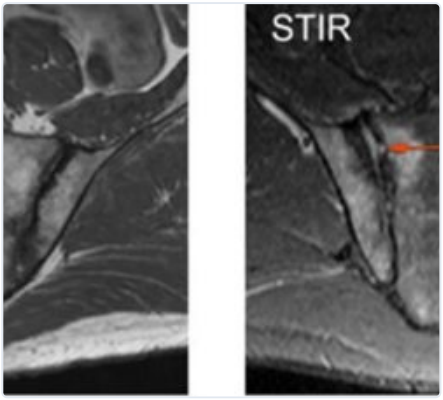
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.018 Pelviespondilopatías seronegativas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Uveítis anterior o posterior

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Espondilitis Anquilosante predomina en varones jóvenes (**15 a 30 años**) y se asocia en > **90%** al HLA-B27.
- El Test de Schöber patológico (< **5 cm** de aumento) demuestra rigidez de la columna lumbar.
- La expansión torácica menor a **2.5 cm** traduce anquilosis costovertebral con patrón restrictivo.
- El criterio radiológico diagnóstico mandatorio es la Sacroilitis bilateral Grado **≥ 2 o** unilateral Grado 3-4.
- La complicación extraarticular más frecuente es la Uveítis Anterior Aguda Unilateral no granulomatosa recurrente.



RM: SACROILITIS, T1 Y STIR
Manual AMIR Reumatología, p. 79

ALGORITMO · ALGORITMO TERAPÉUTICO: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

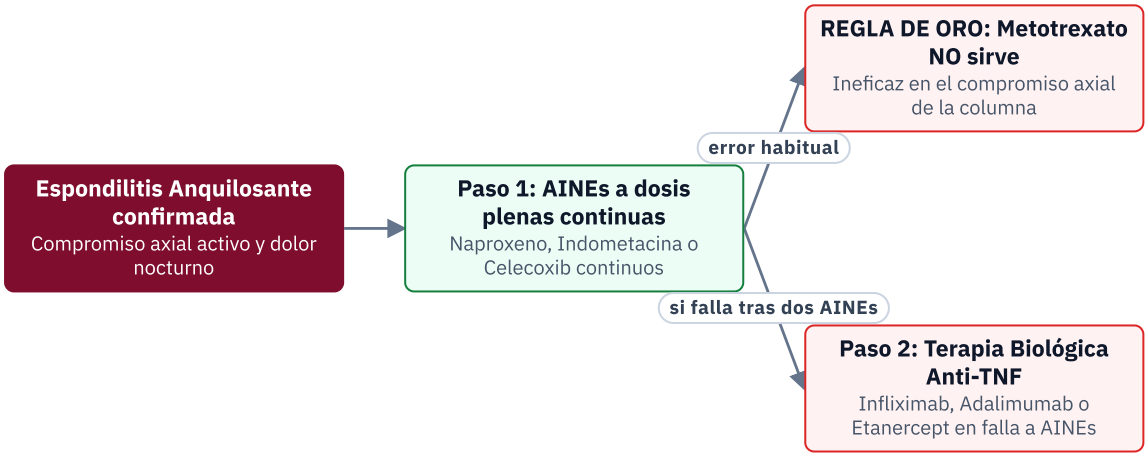


TABLA 9.17 · HALLAZGOS RADIOLÓGICOS PROGRESIVOS EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

REGIÓN ANATÓMICA	FASE PRECOZ / INCIPIENTE	FASE AVANZADA / ANQUILOSIS
Articulaciones Sacroilíacas	Pseudoensanchamiento articular por erosiones subcondrales	Esclerosis masiva y fusión ósea total (sacroilitis grado 4)
Cuerpos Vertebrales	Cuadratura vertebral (squaring) y erosiones en esquinas (Romanus)	Esquinas brillantes (osteosclerosis reactiva)
Espacios Intervertebrales	Sindesmofitos verticales delgados marginales incipientes	Sindesmofitos continuos en "Columna en caña de bambú"
Ligamentos de la Columna	Inflamación y calcificación del ligamento interespinoso	Signo de la vía del tren o del puñal (osificación ligamentosa continua)

TRAMPAS EUNACOM

PATOLOGÍA	EDAD HABITUAL	TIPO DE PROLIFERACIÓN ÓSEA	ARTICULACIONES SACROILÍACAS
Espondilitis Anquilosante	Varones jóvenes de 15 a 30 años	Sindesmofitos finos y verticales en caña de bambú	SACROILITIS OBLIGATORIA (bilateral simétrica)
Artrosis de Columna (Espondilosis)	Mayores de 50 años	Osteofitos gruesos marginales horizontales	Sacroilíacas estrictamente normales
Hiperostosis Esquelética Difusa (DISH)	Varones mayores de 60 años con diabetes	Calcificación ligamentosa anterior en cera derretida	Sacroilíacas estrictamente normales sin sacroilitis

REGLA DE ORO **Varón joven con rigidez de Schöber** — Menor a cinco centímetros y sacroilitis obligatoria

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **60–64** (págs. 15–16) · solucionario págs. 35–36.

Clase 9.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

★★★ PRIORIDAD ALTA
25 preguntas reales 2013–2025

Alta · Evaluación frecuente de dactilitis ("dedo en salchicha") y alteraciones ungueales

1.11.1.001 Artritis psoriática — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Enfermedad inflamatoria intestinal · Pelviespondilopatías seronegativas

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Artritis Psoriásica afecta al **15-30%** de los pacientes con psoriasis cutánea.
- La Dactilitis ("dedo en salchicha") es la tumefacción difusa de todo el dedo por artritis más tenosinovitis flexora.
- El compromiso de interfalángicas distales (IFD) con distrofia ungueal (pitting) es característico de psoriasis.
- La radiografía muestra la imagen típica en "lápiz en copa" (pencil-in-cup) con erosión y proliferación ósea.
- El Metotrexato es el FARME sintético de primera elección en artritis psoriásica periférica.
- En la Colitis Ulcerosa, la artritis periférica Tipo 1 sigue un curso PARALELO a los brotes digestivos.
- El compromiso axial en EII (espondilitis) es INDEPENDIENTE de la actividad intestinal.



PSORIASIS EN PLACAS
Manual AMIR Dermatología, p. 39

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: ARTRITIS PSORIÁSICA Y ARTROPATÍA EN EII

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

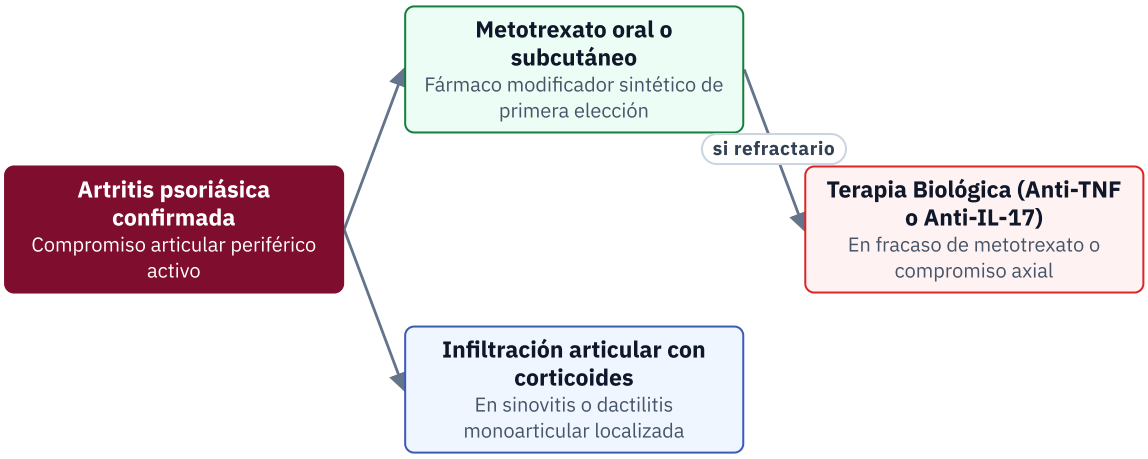


TABLA 9.18 · DIFERENCIAS ENTRE ARTRITIS PERIFÉRICA TIPO 1 Y AFECCIÓN AXIAL EN EII

CARACTERÍSTICA	ARTRITIS PERIFÉRICA TIPO 1	COMPROMISO AXIAL (ESPONDILITIS EII)
Articulaciones afectadas	Grandes articulaciones (< 5 art: rodillas, tobillos)	Articulaciones sacroilíacas y columna vertebral
Relación con brotes intestinales	PARALELA: Coincide con crisis de diarrea/rectorragia	INDEPENDIENTE: No guarda relación con actividad intestinal
Efecto de la colectomía en CU	Cura o induce remisión de la artritis	NULO: La espondilitis continúa progresando
Asociación con HLA-B27	Baja (~10%)	Muy ALTA (50 – 70%)
Pronóstico articular	No destructiva, no deja secuelas	Progresiva con sindesmofitos y anquilosis

REGLA DE ORO **Dactilitis y piqueteado ungueal** — Dedo en salchicha e interfalángicas distales afectadas

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **65–68** (pág. 16) · solucionario pág. 36.

Clase 9.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.002 Artritis reactivas — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Enfermedades de transmisión sexual · Oligoartritis

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Artritis Reactiva se desarrolla **1 a 4 semanas** tras una infección urogenital (Chlamydia) o digestiva.
- **La Tríada de Reiter comprende**: 1) Uretritis no gonocócica, 2) Conjuntivitis estéril y 3) Oligoartritis asimétrica.
- Afecta predominantemente las articulaciones de extremidades inferiores (rodillas, tobillos, dedos del pie).
- Las lesiones mucocutáneas clásicas son la Balanitis Circinada y la Queratodermia Blenorrágica palmoplantar.
- El líquido sinovial es inflamatorio pero ESTÉRIL (Gram y cultivos bacterianos negativos).
- **Tratamiento articular de primera línea**: AINEs a dosis plenas continuas.



BALANITIS CIRCINADA
Manual AMIR Reumatología, p. 83

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: OLIGOARTRITIS ASIMÉTRICA Y SOSPECHA DE ARTRITIS REACTIVA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

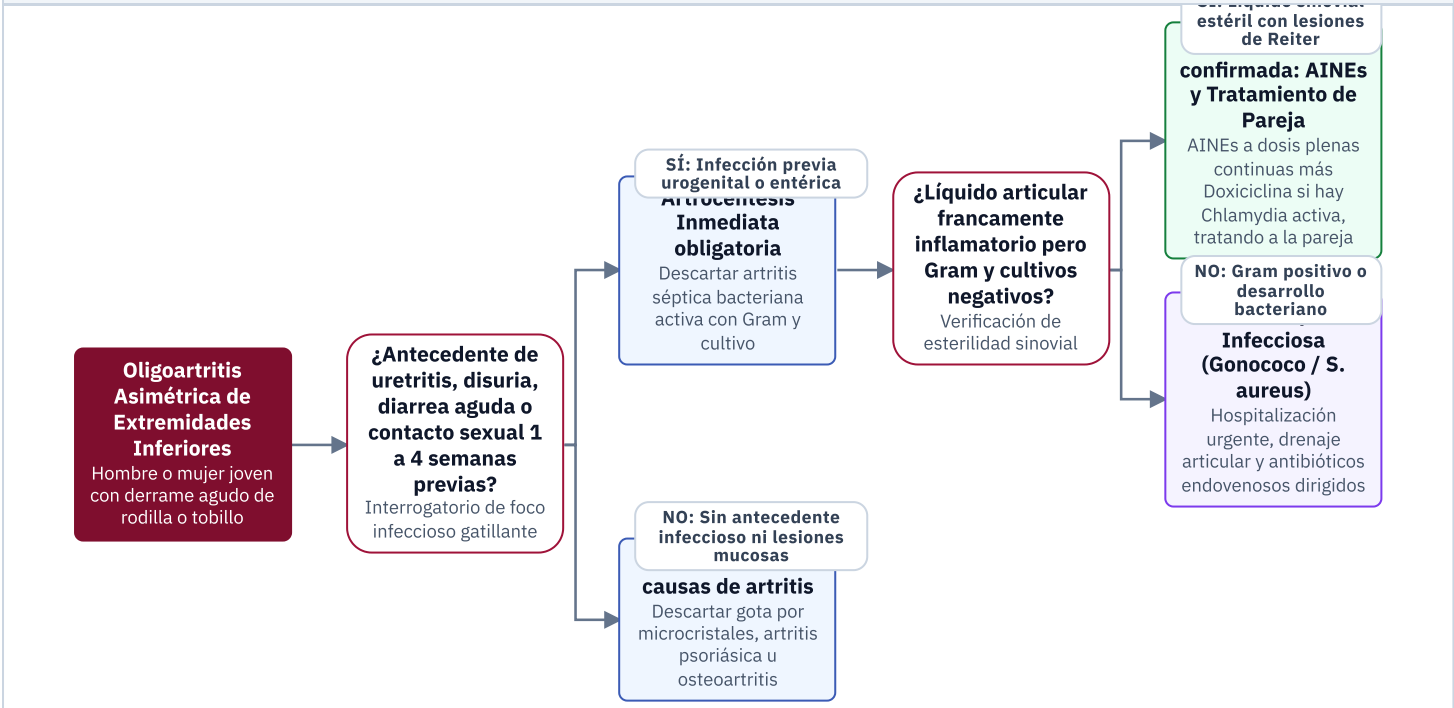


TABLA 9.19 · ESPECTRO CLÍNICO DEL SÍNDROME DE REITER / ARTRITIS REACTIVA

SISTEMA ORGÁNICO	MANIFESTACIÓN CLÍNICA TÍPICA	SIGNO SEMIOLÓGICO CLAVE
Articular	Oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores	Derrame en rodilla, tobillo y dactilitis en pie
Genitourinario	Uretritis no gonocócica / cervicitis	Secreción uretral mucoide y disuria
Ocular	Conjuntivitis no infecciosa / Uveítis anterior	Ojo rojo estéril transitorio
Cutáneo genital	Balanitis circinada	Erosiones serpiginosas indoloras en glande
Cutáneo acral	Queratodermia blenorrágica	Placas hiperqueratósicas en palmas y plantas
Mucoso oral	Aftas orales superficiales	Úlceras mucosas no dolorosas en paladar/lengua

REGLA DE ORO **Uretritis, conjuntivitis y oligoartritis** — Aparición una a cuatro semanas postcontacto

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **1, 69–70** (págs. 8, 16–17) · solucionario págs. 21, 37.

Clase 9.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

9.20 Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

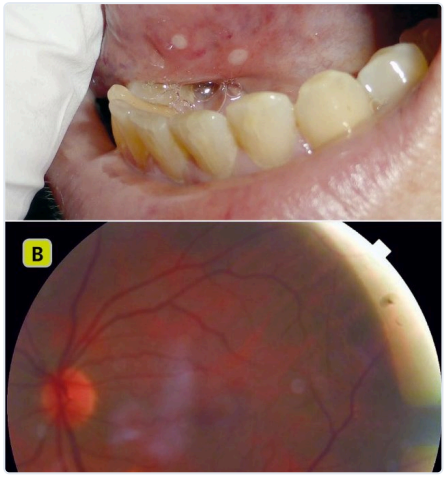
★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.025 Vasculitis sistémicas — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Uveítis anterior o posterior

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Enfermedad de Behçet es una vasculitis de vasos de cualquier calibre asociada a HLA-B51.
- Las aftas orales son dolorosas, recurrentes (**≥ 3 veces/año**) y curan SIN dejar cicatriz.
- Las aftas genitales (escrotales o vulvares) son muy dolorosas y DEJAN CICATRIZ atrófica permanente.
- La complicación ocular grave es la panuveítis y la uveítis anterior con hipopión estéril.
- El fenómeno de Patergia consiste en la aparición de una pústula estéril **24-48h** tras pinchar la piel con una aguja.
- La afección vascular incluye trombosis venosas profundas recurrentes y aneurismas de arteria pulmonar.



AFTAS ORALES Y FONDO DE OJO
Manual AMIR Reumatología, p. 41

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE BEHÇET

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

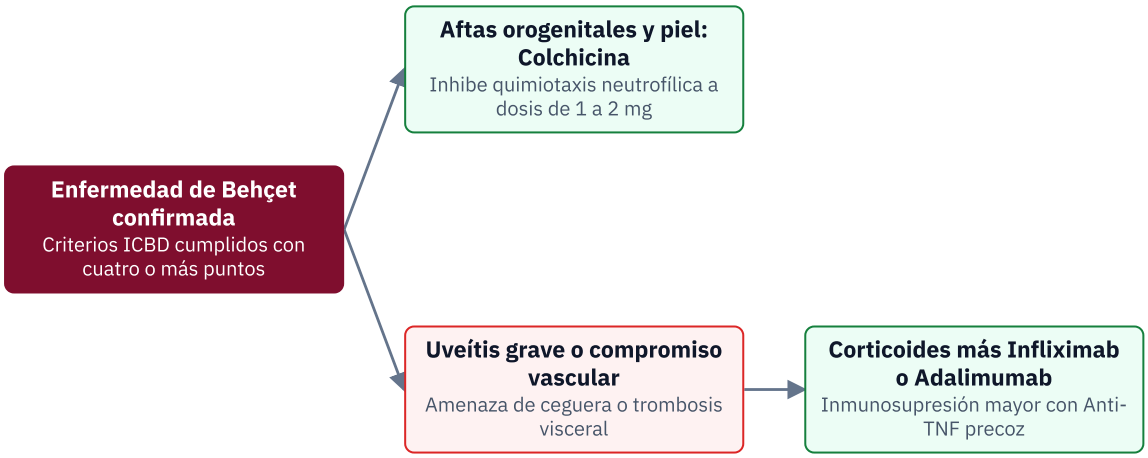


TABLA 9.20 · CRITERIOS INTERNACIONALES PARA LA ENFERMEDAD DE BEHÇET (ICBD)

MANIFESTACIÓN CLÍNICA	PUNTAJE ASIGNADO (CORTE ≥ 4 PUNTOS)	DETALLE CLÍNICO
Aftas Bucales Recurrentes	2 puntos	≥ 3 episodios en 12 meses; curan sin cicatriz
Aftas Genitales Recurrentes	2 puntos	En escroto o vulva; DEJAN cicatriz atrófica
Lesiones Oculares (Uveítis)	2 puntos	Uveítis anterior con hipopión, panuveítis, vasculitis retiniana
Lesiones Cutáneas	1 punto	Pseudofoliculitis, eritema nodoso, pápulas acneiformes
Manifestaciones Vasculares	1 punto	Trombosis venosa profunda, tromboflebitis, aneurismas arteriales
Prueba de Patergia Positiva	1 punto	Pústula estéril a las 24-48 horas tras punción cutánea
Manifestaciones del SNC	1 punto	Neuro-Behçet: meningitis aséptica, trombosis de senos durales

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

MANIFESTACIÓN CLÍNICA	PUNTAJE ASIGNADO (CORTE >= 4)	DETALLE SEMIOLÓGICO CLAVE
Fenómeno de Patergia / Piel	1 punto cada uno	Pústula estéril a 24-48h · Eritema nodoso en piernas

REGLA DE ORO **La regla de oro de las cicatrices** — Aftas orales sin cicatriz y aftas genitales con cicatriz

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **71–72** (pág. 17) · solucionario pág. 37.

Clase 9.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta · Urgencia médica de pérdida visual irreversible y pregunta angular del Perfil V3

1.11.1.025 **Vasculitis sistémicas** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Neuropatía óptica isquémica · Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

LO QUE TE PREGUNTAN

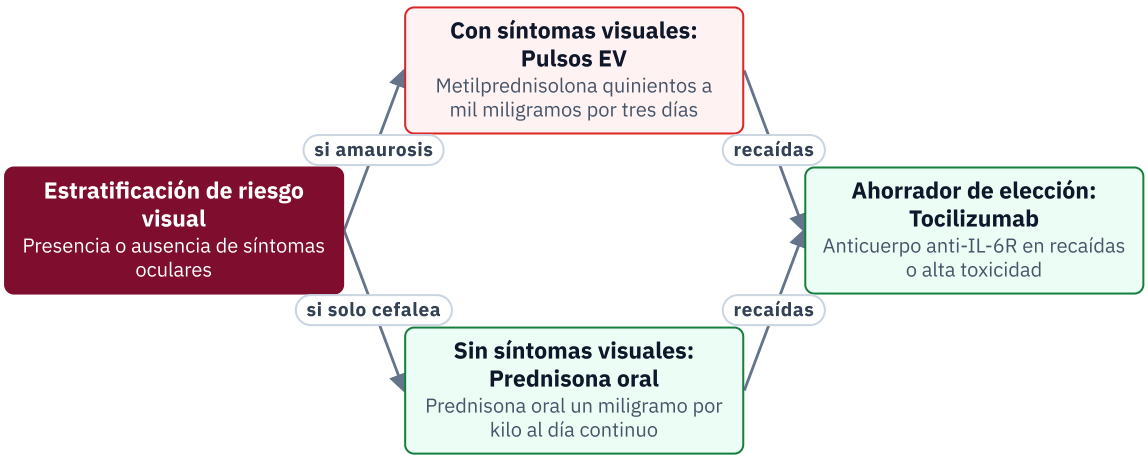
- La arteritis de la temporal es exclusiva de mayores de **50 años**; su complicación temida es la ceguera por NOIAA.
- La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> **90%**) de arteritis de células gigantes.
- Ante síntomas visuales (amaurosis fugax, diplopía), iniciar BOLOS DE METILPREDNISOLONA EV **500-1.000 mg**/día x **3 días**.
- NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos persisten por **2 a 4 semanas**.
- La biopsia de arteria temporal requiere una longitud **≥ 1.5-2 cm** para evitar falsos negativos por "skip lesions".
- Tocilizumab (anti-IL-6R) es el fármaco biológico ahorrador de corticoides de primera línea aprobado en arteritis temporal.



NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · ALGORITMO DE EMERGENCIA: VASCULITIS DE GRAN CALIBRE (TEMPORAL Y TAKAYASU)

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **77–81** (pág. 18) · solucionario págs. 38–39.

Clase 9.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 9.21 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIÓN DE BIOPSIA DE ARTERIA TEMPORAL (ACR 1990 / ACTUALIZACIÓN 2022)

CRITERIO DIAGNÓSTICO	DEFINICIÓN CLÍNICA / PARÁMETRO OPERATIVO	SENSIBILIDAD / RENDIMIENTO	CONDUCTA REUMATOLÓGICA OBLIGATORIA
Edad al inicio	Aparición de síntomas en paciente de edad ≥ 50 años	> 99% (criterio de inclusión casi universal)	En menores de 40 años sospechar Takayasu u otra vasculitis
Cefalea de nuevo inicio	Dolor localizado reciente, unilateral, frontotemporal u occipital	70% – 85%	Investigar características diferenciales de cefaleas previas
Anomalía arterial temporal	Engrosamiento, hipersensibilidad al tacto o disminución de pulso	60% – 70%	Palpar ambos trayectos temporales y ramas frontoparietales
Reactantes de fase aguda	VSG acelerada ≥ 50 mm/h (Westergren) y/o PCR muy elevada	> 95% combinadas	Una VSG normal no descarta 100% si la clínica y PCR son altas
Biopsia arterial compatible	Panarteritis granulomatosa transmural y fragmentación elástica	Estándar de oro (85% – 90%)	Tomar fragmento quirúrgico ≥ 1.5-2 cm; no postergar corticoides
Ecografía Doppler arterial	Signo del halo hipoecoico circunferencial en corte transversal	Sensibilidad 75%, Especificidad > 90%	Alternativa o complemento útil previo a la biopsia quirúrgica

TRAMPAS EUNACOM

PARÁMETRO CLÍNICO	ARTERITIS DE LA TEMPORAL	ARTERITIS DE TAKAYASU
Edad típica y sexo	Mayores de 50 años (pico 70 a 80 años)	Mujeres jóvenes menores de 40 años
Vasos afectados	Ramas de carótida externa (temporal, maxilar)	Aorta y grandes troncos supraaórticos y renales
Clínica distintiva	Cefalea, claudicación mandibular y amaurosis	Asimetría de pulsos, soplos y claudicación de brazos

REGLA DE ORO **Regla de oro: Jamás esperar la biopsia** — Iniciar corticoides en el momento exacto de la sospecha

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La arteritis de células gigantes (arteritis temporal) representa la vasculitis sistémica más común en adultos mayores de 50 años y constituye una verdadera emergencia médica. Su complicación más temida es la ceguera monocular o bilateral irreversible secundaria a neuropatía óptica isquémica anterior arterítica (NOIAA). La regla de oro del EUNACOM exige iniciar corticoterapia sistémica enérgica de inmediato ante la sospecha clínica, jamás demorando el fármaco para coordinar una ecografía o biopsia temporal.

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **77–81** (pág. 18) · solucionario págs. 38–39.

Clase 9.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

★★★
PRIORIDAD ALTA
22 preguntas reales 2013–2025

9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

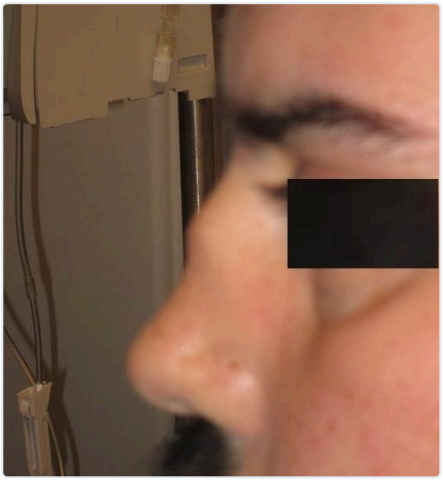
Muy Alta · Prototipo de síndrome riñón-pulmón y emergencias de falla orgánica múltiple

1.11.1.025 **Vasculitis sistémicas** Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

También: Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva · Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros · Púrpuras vasculares · Vasculitis cutáneas

LO QUE TE PREGUNTAN

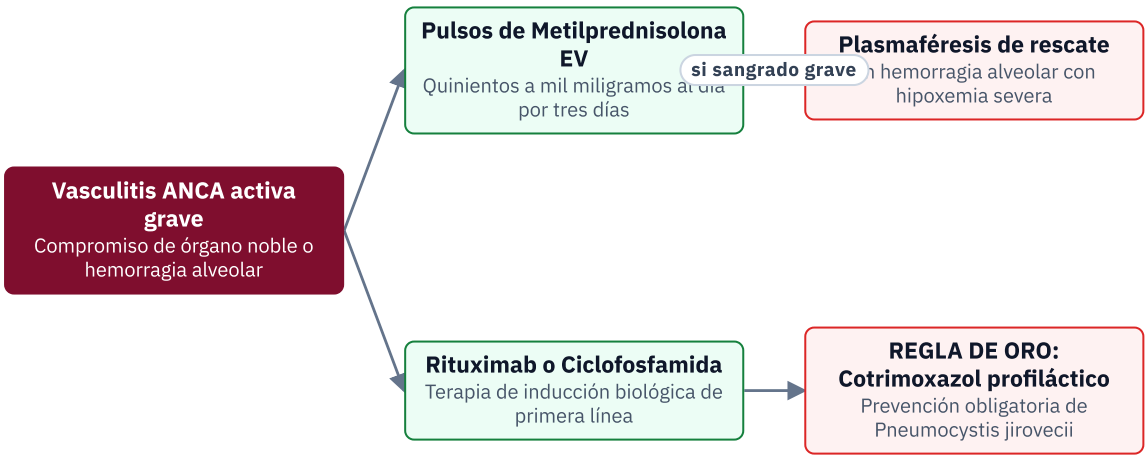
- La GPA (Wegener) cursa clásicamente con c-ANCA (Anti-PR3 positivo) y nódulos pulmonares cavitados bilaterales.
- La perforación del tabique nasal con deformidad en "nariz en silla de montar" es patognomónica de GPA.
- La PAM cursa con p-ANCA (Anti-MPO positivo), GNRP pauciinmune y hemorragia alveolar SIN compromiso de vía alta.
- La EGPA (Churg-Strauss) se define por asma severo del adulto, eosinofilia > 1.500/uL y mononeuritis múltiple.
- En Púrpura de Henoch-Schönlein (IgA), el recuento de plaquetas es NORMAL; plaquetas bajas descartan el diagnóstico.
- La inducción en AAV grave exige bolos de metilprednisolona EV + Rituximab o Ciclofosfamida + cotrimoxazol profiláctico.



NARIZ EN SILLA DE MONTAR
Wikimedia Commons «Saddle nose 38.jpg», CC BY-SA 4.0

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: VASCULITIS DE PEQUEÑO CALIBRE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **82–85** (pág. 19) · solucionario págs. 39–40.

Clase 9.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 9.22 · PATRONES SEROLÓGICOS ANCA, COMPROMISO CLÍNICO RENAL Y PULMONAR EN VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO

VASCULITIS DE PEQUEÑO VASO	MARCADOR SEROLÓGICO PRINCIPAL	COMPROMISO DE VÍA AÉREA Y PULMÓN	COMPROMISO RENAL TÍPICO	HISTOPATOLOGÍA CLAVE
Granulomatosis con Poliangeítis (GPA)	c-ANCA positivo en 85-90% (Anticuerpo Anti-Proteinasa 3 / PR3)	Sinusitis purulenta, nariz en silla de montar, nódulos pulmonares cavitados bilaterales	Glomerulonefritis necrotizante con semilunas pauciinmune (GNRP)	Granulomas necrotizantes intra y extravasculares con necrosis
Poliangeítis Microscópica (PAM)	p-ANCA positivo en 70-80% (Anticuerpo Anti-Mieloperoxidasa / MPO)	Capilaritis pulmonar con hemorragia alveolar difusa; NO hay granulomas ni vía alta	GNRP pauciinmune severa en > 85% de los pacientes; rápida pérdida de VFG	Vasculitis necrotizante sin granulomas; depósitos inmunes escasos
Granulomatosis Eosinofílica (EGPA)	p-ANCA / Anti-MPO en 40-50% (50% seronegativo)	Asma grave del adulto refractaria, pólipos nasales, infiltrados pulmonares fugaces	Glomerulonefritis pauciinmune leve a moderada (menos frecuente que en GPA/PAM)	Infiltración masiva de eosinófilos en tejidos y granulomas eosinofílicos
Vasculitis por IgA (Henoch-Schönlein)	ANCA negativos; elevación de IgA sérica en 50%	Excepcional compromiso alveolar; vía aérea superior respetada	Hematuria glomerular microscópica/macroscópica y proteinuria (Nefritis IgA)	Vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA1 mesangial granular

REGLA DE ORO **GPA: c-ANCA y nariz en silla de montar** — Sinusitis destructiva y nódulos pulmonares cavitados

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las vasculitis necrosantes de vaso pequeño se dividen biológicamente en aquellas mediadas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (AAV: GPA, PAM y EGPA) y aquellas mediadas por depósito de inmunocomplejos (Vasculitis por IgA / Púrpura de Henoch-Schönlein). Constituyen una causa prototípica del síndrome riñón-pulmón y exigen un reconocimiento ultra-precoz: la instauración inmediata de bolos de esteroides e inmunosupresores mayores (Ciclofosfamida o Rituximab) salva al paciente de la muerte por hemorragia alveolar masiva o de la dependencia definitiva de hemodiálisis.

TABLA 9.22.B · PROTOCOLO DE INDUCCIÓN CON CICLOFOSFAMIDA, RITUXIMAB Y CRITERIOS DE PLASMAFÉRESIS

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	RÉGIMEN Y DOSIS ESTÁNDAR	POBLACIÓN / INDICACIÓN PREFERENTE	TOXICIDAD CRÍTICA Y MEDIDAS DE SOPORTE
Bolos de Metilprednisolona EV	500 a 1.000 mg EV cada 24 horas x 3 días consecutivos	Toda forma de vasculitis ANCA grave con riesgo vital u orgánico	Hiperglicemia severa, hipertensión, psicosis esteroidal, sepsis bacteriana
Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m² EV semanal x 4 dosis (o 1.000 mg días 1 y 15)	De elección en jóvenes (preserva fertilidad), recaídas o GPA severa	Reacciones infusionales agudas, hipogammaglobulinemia, reactivación de VHB
Ciclofosfamida (Pulsos EV)	0.5 a 0.75 g/m² EV mensual x 3 a 6 meses + Mesna	Alternativa en falla renal catastrófica o falta de acceso a Rituximab	Cistitis hemorrágica (prevenida con Mesna e hidratación), mielosupresión
Plasmaféresis (Recambio Plasmático)	6 a 7 sesiones de 40 a 60 mL/kg de plasma en 14 días	Hemorragia alveolar con hipoxemia severa o creatinina > 5.7 mg/dL	Hipotensión por volemia, coagulopatía de consumo, infecciones por catéter
Cotrimoxazol profiláctico	160/800 mg (1 comprimido fuerte) oral 3 veces por semana	Obligatorio en todo paciente bajo Rituximab o Ciclofosfamida	Prevenir neumonía fatal por Pneumocystis jirovecii; controlar hemograma

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **82–85** (pág. 19) · solucionario págs. 39–40.

Clase 9.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

9.23 Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.010 **Fibromialgia** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Prevención de complicaciones de la terapia esteroidal

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Polimialgia Reumática afecta a personas > **50 años** con dolor y rigidez matinal > **45 min** en hombros y caderas.
- En la PMR la VSG y la PCR están marcadamente elevadas, mientras que la CPK es rigurosamente NORMAL.
- La PMR responde de forma rápida y espectacular a Prednisona a dosis bajas (**15 a 20 mg**/día) en **48 a 72 horas**.
- La Fibromialgia es un dolor nociplástico por sensibilización central con VSG, PCR y CPK estrictamente NORMALES.
- Los corticoides y los opioides están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en el tratamiento de la Fibromialgia.

ALGORITMO · ALGORITMO DIFERENCIAL: DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO PROXIMAL VS GENERALIZADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

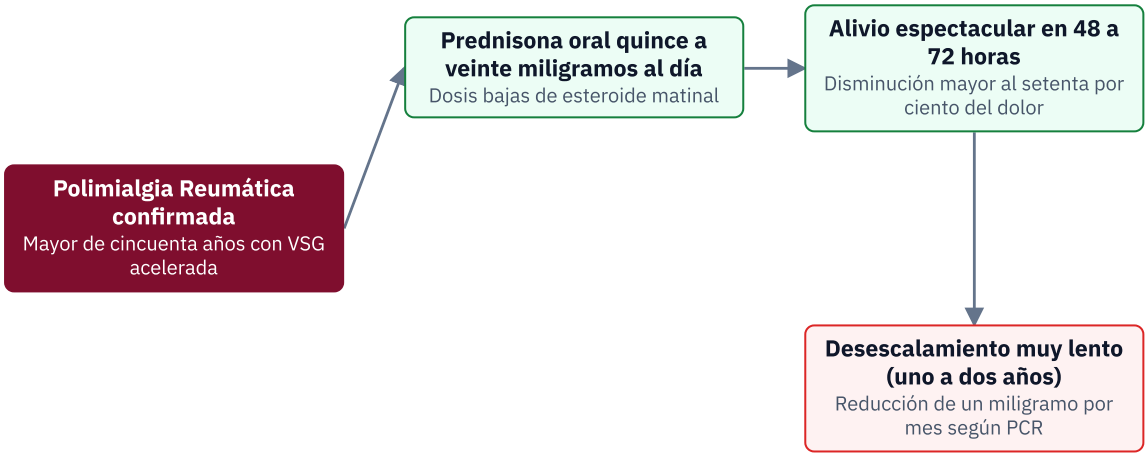


TABLA 9.23 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO, ANALÍTICO Y FARMACOLÓGICO: FIBROMIALGIA VS POLIMIALGIA REUMÁTICA

PARÁMETRO DIFERENCIAL	POLIMIALGIA REUMÁTICA (PMR)	FIBROMIALGIA (FM)	RELEVANCIA EUNACOM
Edad habitual de inicio	Siempre mayores de 50 años (pico > 70 años)	Mujeres jóvenes y edad media (20 – 55 años)	Edad < 50 años descarta prácticamente PMR
Naturaleza biológica	Enfermedad inflamatoria sistémica (sinovitis/bursitis)	Trastorno nociplástico por sensibilización central	PMR es inflamatoria; Fibromialgia es funcional/neuromodulada
Localización del dolor	Cinturas escapular y pélvica bilateral simétrica	Dolor difuso generalizado en 4 cuadrantes corporales	PMR no duele en manos ni pies distales; FM duele difuso
Rigidez matinal	Severa, prolongada (habitualmente > 45 a 60 minutos)	Variable, subjetiva, referida como "agarrotamiento"	En PMR el paciente no puede salir de la cama ni vestirse
Fuerza muscular y CPK	Fuerza normal (inhibida por dolor); CPK NORMAL	Fuerza muscular normal; CPK ESTRICTAMENTE NORMAL	CPK elevada orienta a miositis inflamatoria, no a PMR ni FM
Reactantes de fase aguda	VSG muy acelerada (> 50-100 mm/h) y PCR muy alta	VSG y PCR RIGUROSAMENTE NORMALES	Una VSG alta descarta FM pura; una VSG normal descarta PMR
Asociación sistémica	Arteritis de células gigantes / temporal (15% – 20%)	Colon irritable, cefalea tensional, depresión/ansiedad	En PMR pesquisar siempre cefalea temporal y claudicación
Respuesta a corticoides	ESPECTACULAR a Prednisona 15-20 mg/día (alivio en 48-72h)	NULA o deletérea (CONTRAINDICADOS FORMALMENTE)	Pregunta fija: PMR responde a dosis bajas; FM NUNCA corticoides

REGLA DE ORO **Mayores de cincuenta años con VSG acelerada** — Dolor y rigidez matinal de hombros y caderas con CPK normal

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **86–88** (pág. 19) · solucionario pág. 41.

Clase 9.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

1.11.1.017
1.03.1.018
Osteoporosis

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Densitometría ósea · Factores de riesgo de osteoporosis

LO QUE TE PREGUNTAN

- Una fractura por fragilidad en cadera o vértebra define automáticamente OSTEOPOROSIS sin requerir densitometría.
- **Densitometría OMS**: Normal T-score ≥ -1.0; Osteopenia -1.0 a -2.5; Osteoporosis T-score ≤ -2.5 DE.
- El T-score se utiliza en posmenopáusicas y varones **≥ 50 años**; el Z-score se utiliza en jóvenes (< **50 años**).
- Un Z-score ≤ -2.0 DE obliga a descartar sistemáticamente causas secundarias de pérdida ósea (corticoides, Cushing).
- El Alendronato exige ayuno estricto, vaso con agua pura y bipedestación por **30 a 60 min** para prevenir esofagitis.

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO: OSTEOPOROSIS

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 9.24 · CRITERIOS DENSITOMÉTRICOS OMS Y POSOLOGÍA FARMACOLÓGICA EN OSTEOPOROSIS

FÁRMACO / CLASIFICACIÓN	CRITERIO OPERATIVO / DOSIS TERAPÉUTICA	VÍA Y FRECUENCIA DE USO	INDICACIÓN / PRECAUCIONES CLÍNICAS CLAVE
DMO Normal	T-score ≥ -1.0 DE en columna o cadera	Tamizaje preventivo	Dieta equilibrada en calcio, actividad física y cesación tabáquica
Osteopenia	T-score entre -1.0 y -2.5 DE	Seguimiento con FRAX	Tratar si FRAX mayor ≥ 20% o cadera ≥ 3%; soporte con Calcio/Vit D
Osteoporosis	T-score ≤ -2.5 DE o fractura fragilidad	Tratamiento farmacológico	Iniciar bifosfonato de primera línea + calcio elemental y vitamina D
Alendronato sódico	70 mg comprimido vía oral	Una vez por semana en ayuno	Tomar con vaso de agua pura; bipedestación estricta 30-60 min; ClCr > 35
Ácido Zoledrónico	5 mg solución en infusión endovenosa	Una vez al año (infusión en 15 min)	De elección si intolerancia oral o fractura de cadera; vigilar calcemia

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PATOLOGÍA	CALCIO Y FÓSFORO SÉRICO	FOSFATASAS ALCALINAS	HALLAZGO DISTINTIVO
Osteomalacia por déficit de Vitamina D	Calcio y Fósforo DISMINUIDOS	Fosfatasas alcalinas MUY ELEVADAS	Defecto de mineralización osteoide · Líneas de Looser-Milkman
Mieloma Múltiple en ancianos	Hipercalcemia frecuente	Normales (no osteoblásticas)	Lesiones líticas en sacabocado sin halo esclerótico y anemia

REGLA DE ORO **Fractura por bajo impacto es Osteoporosis directa** — No requiere densitometría para iniciar tratamiento

PRACTICA **Libro Gordo Reumatología**, preguntas **89–90** (págs. 19–20) · solucionario págs. 41–42.

Clase 9.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 24 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR	
9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	pág. 3
Nunca esperar el cultivo — Demora **48 a 72 horas**	TIEMPO
Aspirar todo lo posible — Aguja 18 a 21 G, jeringa de **10 a 20 mL**	DOSIS
9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	pág. 4
Daptomicina como alternativa — **8 a 10 mg/kg** al día	DOSIS
Cefazolina **2 g** EV cada **8 h** — O cloxacilina **2 g** EV cada **4 horas**	DOSIS
Estreptococos: **15 a 20%** — Pyogenes, agalactiae y pneumoniae	CORTE
9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	pág. 5
Meta de uricemia < **6.0 mg/dL** — Menor a 5.0 si tiene tofos palpables	DOSIS
Pseudogota con > 100.000 GB — Líquido extremadamente turbio	CORTE
Colchicina **0.5 mg** al día — Por **3 a 6 meses** continuos	DOSIS
9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	pág. 6
Paracetamol hasta **3 a 4 g** al día — El fármaco de inicio recomendado	DOSIS
Rigidez matinal · Breve (< **15 a 30 minutos**) · Prolongada (> **45 a 60 minutos**)	CORTE
9.5 Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto	pág. 7
La ferritina sérica en la Enfermedad de Still del adulto se eleva a cifras extremas (> 1.000-5.000 ng/mL).	DOSIS
Fiebre intermitente mayor a **39 °C** — De una semana o más de evolución	TIEMPO
BLOQUE 02 · ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO	
9.6 Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	pág. 8
Duración **≥ 6 semanas** · 1 punto	CORTE
FR o Anti-CCP positivo a títulos bajos (**≤ 3x** VN) · 2 puntos	CORTE
> 10 articulaciones afectadas (al menos 1 pequeña) · 5 puntos	CORTE
Meta: remisión, DAS28 bajo 3,2 — Control cada **1 a 3 meses**; sin tabaco	META
9.7 Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	pág. 9
15 a 25 mg una vez por semana — Vía oral o subcutánea	DOSIS
Ácido fólico **5 mg** semanales — Administrado **24 a 48 horas** post MTX	DOSIS
15 a 25 mg una vez por semana — Con ácido fólico **5 mg** semanal obligatorio	DOSIS
9.8 Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal	pág. 10
El Anti-Smith (Sm) es el anticuerpo MÁS ESPECÍFICO de LES (> **99%**).	CORTE
9.9 Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora	pág. 11
Pulsos de metilprednisolona — **500 a 1.000 mg** al día por **3 días**	DOSIS
Mantención mínima de **3 a 5 años** — Micofenolato o azatioprina	CORTE
9.10 Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas	pág. 12
Anticuerpos Anti-Histona · Positivos en **50 – 60%** · Positivos en > **95%** de los casos	CORTE
Discoide aislado: **5 a 10%** evoluciona — Subagudo: cerca de la mitad cumple criterios	CORTE
BLOQUE 03 · ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES	
9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	pág. 13
Aspirina **100 mg** más Enoxaparina **40 mg** SC — Hasta seis semanas postparto	DOSIS
Trombosis antes de los **45 a 50 años** sin causa — O recurrente, o en lugar inusual	CORTE
Los anticuerpos deben confirmarse en al menos 2 ocasiones separadas por un mínimo de **12 semanas**.	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal	pág. 15
Complicación renal · Crisis Renal Esclerodérmica (**10-15%**) · Excepcional / Muy rara	CORTE
9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	pág. 16
Corticoides a dosis altas y ahorradores — Prednisona **1 mg/kg**/día más metotrexato	DOSIS
Tamizaje de cáncer oculto obligatorio — Hasta un **30%** paraneoplásico en adultos	CORTE
Población más afectada · Adultos > **20 años**; rara en niños · Bimodal: Forma juvenil (**5-14 años**) y adultos (> **50 años**)	CORTE
9.14 Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	pág. 18
Edad de inicio · Típicamente **15 – 30 años** (mujeres jóvenes) · Típicamente > **30 – 40 años**	CORTE
9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	pág. 19
Ciclosporina tópica **0,05%** — La indica el oftalmólogo si persiste	CORTE
Pilocarpina **5 mg** cada **8 horas** — Cuidado en asma, glaucoma de ángulo estrecho y bradicardia	DOSIS
BLOQUE 04 · ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET	
9.16 Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	pág. 20
Alivio espectacular en **24 a 48 horas** — Respuesta excelente a dosis plenas de AINEs	DOSIS
Respuesta a AINEs · Espectacular y rápida (alivio > **75%** en **24-48h**) · Parcial o modesta	CORTE
AINE por pocos días, relajante hasta **1 semana** — Naproxeno **500 mg** cada **12 horas** o ibuprofeno	DOSIS
9.17 Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	pág. 21
Oftalmología en **24 horas** — La demora deja secuelas	TIEMPO
El Test de Schöber patológico (< **5 cm** de aumento) demuestra rigidez de la columna lumbar.	CORTE
Anterior: la más frecuente — Cerca del **75%**; iritis e iridociclitis	CORTE
9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII	pág. 22
Brote moderado a grave: corticoides — Prednisona **40 mg**; EV y hospitalizar si es grave	DOSIS
Asociación con HLA-B27 · Baja (**~10%**) · Muy ALTA (**50 – 70%**)	CORTE
La Artritis Psoriásica afecta al **15-30%** de los pacientes con psoriasis cutánea.	CORTE
Diarrea mayor de **4 semanas** con sangre y moco — Dolor abdominal, tenesmo, baja de peso, fiebre, anemia	TIEMPO
9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento	pág. 23
Ceftriaxona IM más azitromicina **1 g** — O doxiciclina **100 mg** cada **12 h** por **7 días**	DOSIS
Consejería, preservativo y parejas — Parejas de los últimos **2 a 3 meses**	TIEMPO
Úlcera: sífilis y herpes — Penicilina benzatina 2,4 millones UI; aciclovir **400 mg** cada **8 h**	DOSIS
La Artritis Reactiva se desarrolla **1 a 4 semanas** tras una infección urogenital (Chlamydia) o digestiva.	TIEMPO
9.20 Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	pág. 24
Aftas Bucales Recurrentes · 2 puntos · **≥ 3 episodios** en **12 meses**; curan sin cicatriz	CORTE
BLOQUE 05 · VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO	
9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	pág. 25
La claudicación mandibular es el síntoma clínico más específico (> **90%**) de arteritis de células gigantes.	CORTE
La biopsia de arteria temporal requiere una longitud **≥ 1.5-2 cm** para evitar falsos negativos por "skip lesions".	CORTE
NUNCA retrasar el corticoide para hacer la biopsia temporal; los hallazgos histológicos persisten por **2 a 4 semanas**.	TIEMPO
9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)	pág. 27
Inmunoglobulina EV **2 g**/kg, dosis única — Más ácido acetilsalicílico	DOSIS
Fármacos, **7 a 10 días** después — Penicilinas, sulfas, AINEs	TIEMPO
Aneurismas coronarios — Hasta **25%** sin tratamiento, menos de **5%** con él	CORTE
Biopsia con inmunofluorescencia directa — De una lesión de menos de **48 horas**	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
9.23 Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	pág. 29
Vacunas y profilaxis — Influenza y neumococo; cotrimoxazol si más de **20 mg**	DOSIS
Parte en **12,5 a 25 mg** y baja muy lento — Casi todos superan **5 mg** por más de **3 meses**	DOSIS
9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	pág. 30
El T-score se utiliza en posmenopáusicas y varones **≥ 50 años**; el Z-score se utiliza en jóvenes (< **50 años**).	CORTE
El Alendronato exige ayuno estricto, vaso con agua pura y bipedestación por **30 a 60 min** para prevenir esofagitis.	TIEMPO

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos		pág. 4
Adulto estándar comunitario	**Cefazolina 2 g EV cada 8 h**	O cloxacilina **2 g** EV cada **4 horas**
Prótesis articular y el biofilm · Rifampicina obligatoria	**Vía oral asociada al antibiótico base**	
9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)		pág. 5
La crisis de pseudogota · Alternativas	**Prednisona 30 a 40 mg al día**	Por **3 a 5 días**, con pauta descendente
9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada		pág. 6
Primera línea analgésica	**Paracetamol hasta 3 a 4 g al día**	El fármaco de inicio recomendado
9.7 Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES		pág. 9
Metotrexato · Ácido fólico obligatorio	**Ácido fólico 5 mg semanales**	Administrado **24 a 48 horas** post MTX
Lavado con colestiramina	**Colestiramina 8 g tres veces al día**	Lavado durante once días consecutivos
9.9 Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora		pág. 11
Pulsos de metilprednisolona	**Prednisona oral en descenso rápido**	Cero coma cinco a un miligramo por kilo al día
9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico		pág. 13
Tratamiento combinado agresivo en UCI	**Heparina no fraccionada endovenosa**	A dosis anticoagulantes plenas
Tratamiento combinado agresivo en UCI	**Pulsos de corticoides y plasmaféresis**	Metilprednisolona un gramo al día más plasmaféresis o IGEV
9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal		pág. 15
Tratamiento especializado · Inmunosupresión o antifibróticos	**Micofenolato o ciclofosfamida; nintedanib o pirfenidona**	
Tratamiento especializado	**Corticoides en dosis altas: contraindicados**	Riesgo de crisis renal esclerodérmica
Rescate farmacológico inmediato	**Captopril oral en dosis rápidamente crecientes**	
Manejo del compromiso cutáneo	**Metotrexato semanal en fase inflamatoria**	Quince a veinte miligramos a la semana
9.14 Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal		pág. 18
Fármacos y tóxicos gatillantes · Fármacos contraindicados en Raynaud	**Betabloqueadores y ergotamínicos**	
9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)		pág. 19
Compromiso sistémico	**Corticoides, inmunosupresores o rituximab**	Vasculitis, neuropatía, glomerulonefritis, citopenias
9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII		pág. 22
Colitis ulcerosa	**Leve a moderada: mesalazina oral y rectal**	5-ASA
Colitis ulcerosa	**Brote moderado a grave: corticoides**	Prednisona **40 mg**; EV y hospitalizar si es grave
9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento		pág. 23
Tratamiento de la artritis: AINEs de primera línea	**Corticoides intraarticulares o Sulfasalazina**	En monoartritis refractaria o curso crónico
Respuesta al tratamiento antimicrobiano	**Ceftriaxona endovenosa inmediata**	Respuesta espectacular del gonococo en cuarenta y ocho horas
Flujo uretral y cervicitis	**Ceftriaxona IM más azitromicina 1 g**	O doxiciclina **100 mg** cada **12 h** por **7 días**

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)		pág. 27
Enfermedad de Kawasaki · Idealmente en los primeros 10 días	**Inmunoglobulina EV 2 g/kg, dosis única**	Más ácido acetilsalicílico
Enfermedad de Kawasaki · Idealmente en los primeros 10 días	**Sigue la fiebre: repetir o corticoides**	Diferir vacunas vivas unos **11 meses**; evitar ibuprofeno
9.23 Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS		pág. 29
Pilares terapéuticos en Fibromialgia	**Duloxetina, Pregabalina o Amitriptilina**	Modulan vías noradrenérgicas y canales de calcio
Pilares terapéuticos en Fibromialgia	**Corticoides y opioides FORMALMENTE CONTRAINDICADOS**	Riesgo de adicción, hiperalgesia y toxicidad severa
9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica		pág. 30
Zoledrónico endovenoso y Denosumab subcutáneo	**Denosumab anti-RANKL en insuficiencia renal**	Sesenta miligramos subcutáneos cada seis meses

GES de Reumatología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía GES en Infección de Prótesis Articular en Adultos Mayores · Manejo urgente en especialista**

Tema **9.2** · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos
`1.11.2.001` · `1.11.5.001` · `1.11.4.002`
pág. 4

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Tratamiento Médico en Personas de 55 Años y Más con Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o Moderada · Endoprótesis de Cadera en Personas de 65 Años y Más con Artrosis Severa**

Tema **9.4** · Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada
`1.11.1.004` · `1.11.4.004` · `4.02.3.003`
pág. 6

GES **Garantía Explícita en Salud: Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) en personas menores de 17 años · Cobertura completa**

Tema **9.5** · Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto
`2.01.1.143` · `1.11.1.019`
pág. 7

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Artritis Reumatoide en personas de 15 años y más · Confirmación y tratamiento completo**

Tema **9.6** · Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares
`1.11.1.003` · `1.11.1.019` · `1.11.4.003`
pág. 8

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Acceso garantizado a FARME sintéticos y biológicos en AR activa**

Tema **9.7** · Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES
`1.11.1.003`
pág. 9

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Lupus Eritematoso Sistémico en personas de 15 años y más · Cobertura integral**

Tema **9.8** · Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal
`1.11.1.014` · `1.11.4.003`
pág. 10

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Nefritis Lúpica · Biopsia renal, inducción y mantenimiento cubiertos**

Tema **9.9** · Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora
`1.09.1.006` · `1.11.1.014`
pág. **11**

GES **Garantía GES en Lupus Eritematoso Sistémico · Formas cutáneas exclusivas requieren derivación dermatológica**

Tema **9.10** · Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas
`6.01.1.016` · `1.11.1.014`
pág. **12**

GES **Garantía GES en Anticoagulación y Patología Reumatológica Asociada · Manejo integral especialista**

Tema **9.11** · Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico
`1.11.1.021` · `1.08.1.019`
pág. **13**

GES **Garantía Explícita en Salud: Tratamiento de Espondiloartritis con Biológicos Anti-TNF en centros especializados**

Tema **9.17** · Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF
`1.11.1.018` · `6.02.1.030`
pág. **21**

GES **Garantía GES en Insuficiencia Renal Crónica Terminal (GES N° 1) · Manejo reumatológico terciario urgente**

Tema **9.22** · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)
`1.11.1.025` · `1.09.2.013` · `2.01.1.058`
pág. **27**

GES **Manejo en Atención Primaria de Salud (APS) · Sin garantía GES específica**

Tema **9.23** · Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS
`1.11.1.010` · `1.11.3.002`
pág. **29**

GES **Garantía GES en Tratamiento Quirúrgico de Fractura de Cadera en Adultos Mayores (GES N° 10) y Órtesis**

Tema **9.24** · Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica
`1.11.1.017` · `1.11.4.001` · `1.03.1.018`
pág. **30**

Sin garantía GES específica (11 temas): 9.1 · 9.3 · 9.12 · 9.13 · 9.14 · 9.15 · 9.16 · 9.18 · 9.19 · 9.20 · 9.21. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **9.18** Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII 22
- ★★★ **9.22** Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) 27
- ★★★ **9.19** Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento 23
- ★★★ **9.6** Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares 8

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 1–2, 20–23, 65–70, 82–85.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **9.7** Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES 9
- ★★★ **9.2** Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos 4
- ★★★ **9.3** Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) 5
- ★★★ **9.20** Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis 24

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 9–17, 24–27, 71–72.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **9.13** Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto 16
- ★★☆ **9.17** Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF 21
- ★★☆ **9.21** Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu 25
- ★★☆ **9.24** Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica 30

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 48–52, 60–64, 77–81, 89–90.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **9.12** Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal 15
- ★★☆ **9.8** Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal 10
- ★★☆ **9.4** Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada 6
- ★★☆ **9.11** Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico 13

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 18, 28–32, 37–47.

DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **9.16** Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico 20
- ★☆☆ **9.1** Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial 3
- ★☆☆ **9.14** Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal 18
- ★☆☆ **9.15** Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) 19

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 3–8, 53–59.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **9.10** Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas 12
- ★☆☆ **9.23** Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS 29
- ★☆☆ **9.9** Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora 11
- ★☆☆ **9.5** Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto 7

Practica: Libro Gordo Reumatología, preguntas 19, 33–36, 86–88.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 31
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 9.2 · 9.3 · 9.6 · 9.7 · 9.18 · 9.19 · 9.20 · 9.22
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Reumatología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

25 9.18. Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII 22
22 9.22. Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) GES 27
18 9.19. Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento 23
11 9.6. Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares GES 8
11 9.7. Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES GES 9
9 9.2. Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos GES 4
9 9.3. Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) 5
9 9.20. Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis 24

★★ Prioridad media · 9 temas

8 9.13. Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto 16
8 9.17. Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF GES 21
8 9.21. Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu 25
7 9.24. Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica GES 30
6 9.12. Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal 15
5 9.8. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal GES 10
4 9.4. Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada GES 6
4 9.11. Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico GES 13
4 9.16. Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico 20

★ Prioridad baja · 7 temas

3 9.1. Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial 3
3 9.14. Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal 18
3 9.15. Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) 19
2 9.10. Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas GES 12
2 9.23. Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS GES 29
1 9.9. Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora GES 11
0 9.5. Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto GES 7